

Buku Ajar

KEPERAWATAN PALIATIF

Dewi Nur Sukma Purqoti • Arie Kusumaningrum
Yulianti • Christina Yeni Kustanti

Editor : Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



Buku Ajar :

Keperawatan Paliatif

Penulis:

Dewi Nur Sukma Purqoti., Ns., M.Kep.

Dr. Arie Kusumaningrum., M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.

Yuliati, SKp., MM., M.Kep.

Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Pall.C., Ph.D.

Editor : Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



Buku Ajar:

Keperawatan Paliatif

Penulis:

Dewi Nur Sukma Purqoti., Ns., M.Kep.

Dr. Arie Kusumaningrum., M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.

Yuliati, SKp., MM., M.Kep.

Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Pall.C., Ph.D.

Editor :

Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-95-4

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI



Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Buku Ajar Keperawatan Paliatif* ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, serta tenaga kesehatan yang ingin memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan paliatif secara komprehensif.

Keperawatan paliatif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit serius, kronis, progresif, maupun kondisi yang mengancam jiwa. Pelayanan paliatif tidak hanya berorientasi pada pengendalian gejala fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, spiritual, komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan, serta dukungan bagi keluarga. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki pemahaman yang kuat, keterampilan klinis yang tepat, serta sikap profesional dan empatik dalam memberikan asuhan paliatif.

Buku ajar ini disusun secara sistematis agar dapat membantu pembaca memahami materi secara bertahap. Bab pertama membahas konsep dasar keperawatan paliatif dan filosofi perawatan sebagai landasan dalam memahami tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pelayanan paliatif. Bab kedua menguraikan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif, termasuk pengkajian kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Bab ketiga membahas manajemen nyeri dalam paliatif sebagai salah satu aspek utama dalam peningkatan kenyamanan pasien. Bab keempat mengulas manajemen sesak napas dan gejala respirasi yang sering dijumpai pada pasien dengan kebutuhan paliatif.

Melalui buku ajar ini, pembaca diharapkan mampu memahami dasar-dasar keperawatan paliatif, melakukan pengkajian kebutuhan pasien secara menyeluruh, serta menerapkan prinsip manajemen gejala secara tepat sesuai dengan peran dan kewenangan perawat. Selain itu, buku ini diharapkan dapat mendorong pembelajaran yang lebih reflektif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta keluarga.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ajar ini.

Akhir kata, semoga *Buku Ajar Keperawatan Paliatif* ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan, peningkatan kompetensi mahasiswa, serta penguatan praktik keperawatan paliatif yang profesional, empatik, dan bermartabat.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
---------------------	-----

Daftar Isi.....	v
-----------------	---

BAB 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN PALIATIF DAN FILOSOFI PERAWATAN . 1

A. Pengertian Keperawatan Paliatif.....	4
B. Tujuan Keperawatan Paliatif.....	5
C. Prinsip-Prinsip Keperawatan Paliatif	6
D. Filosofi Perawatan Paliatif	8
E. Peran Perawat dalam Keperawatan Paliatif	9
F. Ruang Lingkup Keperawatan Paliatif	11
G. Etika dalam Keperawatan Paliatif	12
H. Tantangan dalam Keperawatan Paliatif	13
I. Ringkasan.....	15
J. Latihan Soal.....	18
Referensi	22

BAB 2 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PALIATIF DAN PENILAIAN KOMPREHENSIF 26

A. Definisi dan Filosofi Perawatan Paliatif	29
B. Perbedaan Perawatan Paliatif dengan Perawatan Kuratif.....	31
C. Konsep "Total Pain" (Cicely Saunders)	31
D. Indikasi dan Kriteria Rujukan Perawatan Paliatif.....	32
E. Instrumen Penilaian Paliatif.....	33
F. Penilaian Komprehensif Kebutuhan Paliatif (Bio-Psiko-Sosio-Spiritual).....	34
G. Alur Penilaian Komprehensif Paliatif	36
H. RINGKASAN	37
I. Latihan Soal.....	38
Referensi	42

BAB 3 MANAJEMEN NYERI DALAM PALIATIF 44

A. TEORI DASAR.....	47
B. Fisiologi Nyeri.....	48
C. Fatofisiologi Nyeri.....	50
D. Latihan Soal.....	53
Glosarium	56
Referensi	58

BAB 4 MANAJEMEN SESAK NAPAS DAN GEJALA RESPIRASI.....	60
A. Definisi Sesak Napas & Gejala Respirasi.....	65
B. Etiologi.....	66
C. Faktor Resiko	66
D. Patofisiologi	68
E. Klasifikasi.....	68
F. Manifestasi Klinik	69
G. Pemeriksaan Penunjang	70
H. Intervensi dan Implementasi.....	71
I. Evaluasi	72
J. Edukasi.....	73
K. Dokumentasi.....	74
L. Latihan Soal.....	76
Referensi	80
 Profil Penulis.....	 82

BAB 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN PALIATIF DAN FILOSOFI PERAWATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dan filosofi keperawatan paliatif, pendekatan holistik, serta prinsip kualitas hidup dan patient-centered care.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan penilaian paliatif komprehensif (fisik, psikologis, sosial, spiritual) dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang dan melaksanakan manajemen gejala utama (nyeri, sesak, GI, kelelahan, distres psikologis) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) serta kolaborasi interprofesional dan advokasi pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif termasuk akhir hayat.	CPMK-6; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, discharge/home care planning, serta dukungan caregiver dan bereavement berbasis kebutuhan.	CPMK-7; CPMK-6; CPMK-5

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan paliatif, filosofi perawatan, prinsip kualitas hidup, dan ruang lingkup layanan paliatif.
CPMK-2	Melakukan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif (fisik–psikologis–sosial–spiritual) serta menetapkan prioritas kebutuhan.
CPMK-3	Menerapkan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) dan pengambilan keputusan bersama pasien–keluarga secara etis.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan manajemen nyeri dan gejala utama paliatif berbasis bukti, termasuk monitoring efektivitas dan efek samping.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan akhir hayat dan dukungan keluarga/caregiver (termasuk bereavement care) dengan fokus kenyamanan dan keselamatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan spiritual-budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (home care/rujukan).
CPMK-7	Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta refleksi perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keperawatan Paliatif dan Filosofi Perawatan	1.1 Menjelaskan filosofi paliatif dan fokus kualitas hidup sepanjang perjalanan penyakit.	1.2 Mengidentifikasi prinsip asuhan holistik dan patient-centered care pada konteks paliatif.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-6

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep filosofi paliatif dan ketepatan penerapan prinsip pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	OSCE penilaian paliatif komprehensif + checklist	Kelengkapan penilaian (fisik-psiko-sosio-spiritual) dan ketepatan penetapan prioritas kebutuhan (checklist).	15	Checklist OSCE; lembar penilaian
CPMK-6	Proyek rencana kolaborasi spiritual-budaya & koordinasi layanan	Kualitas pemetaan kebutuhan spiritual-budaya, rencana kolaborasi/rujukan, dan indikator tindak lanjut (skor rubrik).	10	Rencana kolaborasi; peta rujukan

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep paliatif (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan prinsip paliatif pada skenario	Keliru/berisiko	Cukup tepat; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat & komprehensif

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan penilaian komprehensif (checklist)	≤60% komponen terpenuhi; data penting hilang	61–75% terpenuhi; masih ada kekurangan bermakna	76–90% terpenuhi; kekurangan minor	>90% terpenuhi; sangat sistematis
2.2 Ketepatan penetapan prioritas kebutuhan	Prioritas tidak sesuai beban gejala	Cukup sesuai; masih ada ketidaktepatan	Sesuai; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & terdokumentasi

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kualitas komunikasi kabar sulit/ACP	Tidak terstruktur; kurang empatik	Terstruktur sebagian; empati terbatas	Terstruktur; empatik; jelas	Sangat terstruktur; empati tinggi; responsif terhadap nilai pasien
3.2 Kelengkapan tujuan perawatan/ACP terdokumentasi	Tidak lengkap; tidak dapat ditindaklanjuti	Cukup lengkap; masih umum	Lengkap; tujuan spesifik	Sangat lengkap; tujuan sangat spesifik & terukur + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan penilaian gejala & target (nyeri/sesak/GI)	Penilaian tidak tepat; tanpa target	Penilaian cukup; target kurang jelas	Penilaian tepat; target jelas	Penilaian sangat tepat; target spesifik dan realistis
4.2 Ketepatan intervensi & evaluasi respons	Intervensi tidak sesuai; evaluasi tidak ada	Intervensi cukup; evaluasi terbatas	Intervensi sesuai; evaluasi jelas	Intervensi sangat sesuai; evaluasi komprehensif & terdokumentasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan comfort care & keselamatan tindakan	Tidak sesuai tujuan perawatan; risiko tinggi	Cukup sesuai; ada kekurangan bermakna	Sesuai; aman; konsisten	Sangat sesuai; sangat aman; antisipatif komplikasi
5.2 Kualitas dukungan keluarga & bereavement readiness	Tidak responsif; tanpa rencana	Respons ada; rencana umum	Respons baik; rencana tindak lanjut jelas	Dukungan sangat baik; rencana bereavement sangat jelas & terukur

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pemetaan kebutuhan spiritual-budaya & preferensi	Tidak teridentifikasi	Teridentifikasi sebagian	Teridentifikasi jelas	Sangat jelas; mempertimbangkan nilai/ritual kunci
6.2 Kualitas rencana kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak ada rencana; peran tidak jelas	Ada rencana; koordinasi kurang runtut	Koordinasi jelas; indikator tindak lanjut ada	Koordinasi sangat efektif; indikator komprehensif & keberlanjutan kuat

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran paliatif berbasis indikator	Tidak menggunakan indikator	Indikator terbatas; analisis minim	Indikator memadai; analisis jelas	Indikator komprehensif; analisis kritis & akurat
7.2 Kualitas rencana tindak lanjut/home care	Tidak spesifik; tidak terukur	Cukup spesifik; sebagian terukur	Spesifik; terukur; realistis	Sangat spesifik, terukur, realistis; koordinasi layanan jelas

A. Pengertian Keperawatan Paliatif

Keperawatan paliatif merupakan suatu pendekatan asuhan keperawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Pendekatan ini dilakukan melalui pencegahan dan pengurangan penderitaan dengan identifikasi dini, pengkajian yang komprehensif, serta penatalaksanaan nyeri dan masalah lain baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Perawatan paliatif tidak hanya diberikan pada fase akhir kehidupan, tetapi dimulai sejak diagnosis penyakit hingga akhir hayat dengan melibatkan tim

multidisiplin untuk memberikan perawatan yang holistik dan berkesinambungan (World Health Organization, 2020), (Connor & Sepulveda Bermedo, 2018).

Selain itu, keperawatan paliatif juga menekankan peran perawat dalam memberikan dukungan emosional, edukasi kepada pasien dan keluarga, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Hal ini bertujuan agar pasien dapat menjalani kehidupannya dengan nyaman dan bermakna, serta keluarga memperoleh dukungan selama proses perawatan hingga masa berduka (Astuti, Saifudin, & Wisnawa, 2023), (Khairunisa & Handono, 2024a)

B. Tujuan Keperawatan Paliatif

Tujuan utama keperawatan paliatif secara umum untuk mengurangi penderitaan pasien secara menyeluruh, tidak hanya fisik tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan tim multidisiplin (Hidayat et al., 2020). Adapun tujuan lainnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga

Pendekatan paliatif care tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi pada pengalaman hidup pasien secara menyeluruh, termasuk kenyamanan, fungsi sehari-hari, dan kesejahteraan keluarga sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Peningkatan kualitas hidup ini dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga pasien tetap dapat menjalani kehidupan dengan bermakna meskipun dalam kondisi penyakit kronis atau terminal. (Shatri & Sampurna, 2020), (Setyowati, 2023)

2. Mengurangi nyeri dan gejala fisik lainnya

Keperawatan paliatif bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien melalui manajemen nyeri dan gejala lain seperti sesak napas, mual, kelelahan, dan gangguan tidur. Intervensi dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kenyamanan pasien sepanjang perjalanan penyakit (Setyowati, 2023).

3. Memberikan dukungan psikologis dan emosional

Perawatan paliatif membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi stres, kecemasan, dan ketakutan akibat penyakit. Dukungan ini dapat berupa konseling, komunikasi terapeutik, dan pendampingan emosional. Keperawatan paliatif berfokus pada dukungan psikologis bagi pasien dan keluarga, termasuk membantu mengatasi kecemasan, depresi, ketakutan terhadap kematian, serta stres akibat penyakit kronis. Perawat berperan aktif dalam memberikan empati

melalui komunikasi terapeutik, dan pendampingan emosional (Mamnuaah & Trihidayati, 2024).

4. Memberikan dukungan spiritual

Pemenuhan kebutuhan spiritual sangat penting untuk membantu pasien menghadapi penyakit dengan lebih tenang dan bermakna, terutama menjelang akhir kehidupan. Aspek spiritual menjadi bagian penting dalam keperawatan paliatif karena membantu pasien menemukan makna hidup, meningkatkan ketenangan batin, serta kesiapan menghadapi kondisi akhir kehidupan. Pemenuhan kebutuhan spiritual dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pasien palliative secara komprehensif atau keseluruhan (Khairunisa & Handono, 2024b).

5. Membantu pengambilan keputusan perawatan

Perawatan paliatif mendukung pasien dan keluarga dalam membuat keputusan terkait terapi, termasuk pilihan pengobatan, perawatan lanjutan (*advanced directives*), dan preferensi akhir hayat (*advanced care planning*) (Shatri & Sampurna, 2020). Hal tersebut dilakukan melalui komunikasi terbuka antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan agar keputusan sesuai dengan nilai dan keinginan pasien (Sari et al., 2024).

6. Memberikan perawatan secara holistik dan berkesinambungan

Keperawatan paliatif dilakukan secara holistik dan berkesinambungan sejak diagnosis hingga akhir kehidupan, bahkan setelah kematian pasien (dukungan berduka). Pendekatan ini melibatkan tim multidisiplin untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasien (Malaha & al, 2025)

7. Memberikan dukungan kepada keluarga

Keperawatan paliatif tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga keluarga sebagai caregiver. Dukungan diberikan dalam bentuk edukasi, konseling, serta pendampingan selama proses penyakit hingga masa berduka, sehingga keluarga mampu beradaptasi secara emosional dan sosial (Listyarini et al., 2024)

C. Prinsip-Prinsip Keperawatan Paliatif

Beberapa prinsip dasar dalam keperawatan paliatif antara lain:

1. Menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses alami

Prinsip ini menekankan bahwa keperawatan paliatif menghargai kehidupan sebagai sesuatu yang bermakna, sekaligus menerima kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan manusia. Perawatan tidak lagi berfokus pada penyembuhan penyakit, tetapi pada kualitas hidup hingga akhir hayat.

Pendekatan ini membantu pasien menghadapi kematian dengan lebih tenang, bermartabat, dan tanpa penderitaan yang tidak perlu (Shatri & Sampurna, 2020)

2. Tidak mempercepat atau menunda kematian

Perawatan paliatif tidak bertujuan mempercepat kematian (*eutanasia*) maupun menunda kematian secara tidak proporsional. Fokusnya adalah menjaga keseimbangan etis dengan memberikan perawatan yang sesuai kondisi pasien tanpa intervensi yang berlebihan. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama adalah kenyamanan, bukan memperpanjang atau mempersingkat kehidupan secara artifisial (Felenditi, 2013).

3. Mengutamakan kenyamanan pasien (*comfort care*)

Prinsip ini menitikberatkan pada pengurangan nyeri dan gejala lain yang mengganggu, sehingga pasien dapat menjalani sisa hidup dengan nyaman. Intervensi meliputi manajemen nyeri, dukungan psikologis, dan perawatan suportif lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga (Khairunisa & Handono, 2024a)

4. Pendekatan holistik (*bio-psiko-sosial-spiritual*)

Keperawatan paliatif menggunakan pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Artinya, pasien tidak hanya dipandang dari penyakitnya, tetapi sebagai individu utuh dengan kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual yang harus dipenuhi secara bersamaan (Astuti, Saifudin, Wisnawa, et al., 2023).

5. Melibatkan keluarga sebagai bagian dari unit perawatan

Dalam keperawatan paliatif, keluarga dianggap sebagai bagian dari unit perawatan karena mereka berperan penting dalam dukungan emosional, pengambilan keputusan, dan perawatan pasien. Pendekatan ini juga mencakup dukungan bagi keluarga sebelum dan setelah pasien meninggal (Khairunisa & Handono, 2024c)

6. Dilakukan oleh tim multidisiplin

Perawatan paliatif dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan. Kolaborasi ini penting untuk memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif dan optimal (Ratnasari, Fitriyanti, Saptawati, Sari, et al., 2023).

7. Berorientasi pada kebutuhan pasien

Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan keperawatan harus berpusat pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien. Perawatan disesuaikan secara individual melalui komunikasi yang baik dan pengambilan keputusan bersama antara pasien, keluarga, dan tenaga Kesehatan (Shatri & Sampurna, 2020).

D. Filosofi Perawatan Paliatif

Filosofi perawatan paliatif berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap martabat pasien. Filosofi ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perawatan yang bermakna, bermartabat, dan bebas dari penderitaan. Beberapa aspek utama filosofi paliatif:

1. *Human dignity* (martabat manusia).

Setiap pasien diperlakukan dengan hormat karena setiap pasien memiliki nilai intrinsik sebagai manusia yang harus dihormati, terlepas dari kondisi penyakit, prognosis, maupun status sosialnya. Perawat dan tenaga kesehatan berkewajiban menjaga privasi, otonomi, serta hak pasien dalam setiap tindakan perawatan. Pendekatan ini juga mencakup penghargaan terhadap pilihan pasien, terutama dalam kondisi terminal, sehingga keputusan medis tidak hanya berorientasi pada tindakan klinis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai personal pasien. Dalam praktiknya, menjaga martabat pasien berarti memberikan perawatan yang penuh hormat, tidak diskriminatif, serta sensitif terhadap kebutuhan emosional dan spiritual pasien menjelang akhir kehidupan (Chochinov, 2006) (WHO, 2015)

2. *Quality of life* (kualitas hidup).

Perawatan paliatif tidak bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Kualitas hidup dalam konteks ini meliputi aspek fisik (pengendalian nyeri dan gejala), psikologis, sosial, serta lingkungan. Intervensi keperawatan difokuskan pada pengurangan penderitaan dan peningkatan kemampuan pasien untuk menjalani kehidupan dengan bermakna meskipun dalam kondisi penyakit kronis atau terminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perawatan paliatif yang optimal berhubungan signifikan dengan peningkatan kualitas hidup pasien terminal, terutama melalui pendekatan yang komprehensif terhadap berbagai dimensi kebutuhan pasien (Temel et al., 2010) (Ludfiani & Suhartini, 2024)

3. *Holistic care* (perawatan menyeluruh).

Perawatan paliatif bersifat holistik, artinya mencakup seluruh dimensi kehidupan pasien: fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pasien dengan penyakit kronis atau terminal tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga tekanan emosional, perubahan peran sosial, serta krisis spiritual. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin sangat diperlukan, melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, serta dukungan spiritual. Pendekatan biopsikososial-spiritual ini terbukti penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien karena mampu

menjawab kebutuhan pasien secara menyeluruh, bukan hanya aspek medis semata (Mediani et al., 2024) (Ferrell & Coyle, 2015)

4. Patient-centered care (berpusat pada pasien).

Pasien menjadi pusat dari seluruh proses perawatan. Setiap keputusan klinis harus mempertimbangkan kebutuhan, nilai, preferensi, dan harapan pasien serta keluarganya. Dalam perawatan paliatif, hal ini sangat penting karena pasien sering menghadapi kondisi yang kompleks dan membutuhkan keputusan yang sensitif, termasuk terkait perawatan akhir kehidupan. Pendekatan patient-centered care meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui komunikasi yang efektif, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan, serta kolaborasi antar tenaga Kesehatan (Epstein & Street, 2011) (Rosa et al., 2020).

5. *Compassion* (kasih sayang).

Kasih sayang atau compassion merupakan inti dari praktik keperawatan paliatif. Tenaga kesehatan dituntut untuk menunjukkan empati, kepedulian, dan kepekaan terhadap penderitaan pasien. Compassion tidak hanya diwujudkan dalam tindakan klinis, tetapi juga melalui komunikasi yang hangat, kehadiran yang menenangkan, serta dukungan emosional bagi pasien dan keluarga. Dalam praktiknya, compassion membantu membangun hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga pasien merasa dihargai, didukung, dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi penyakitnya. Pendekatan ini juga berkontribusi pada peningkatan pengalaman pasien selama perawatan paliatif (Sinclair et al., 2016) (Saunders, 2003).

E. Peran Perawat dalam Keperawatan Paliatif

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan paliatif, antara lain:

1. Mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif

Perawat memiliki peran utama dalam melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap kondisi pasien paliatif, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Perawat melakukan pengkajian menyeluruh meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pengkajian ini menjadi dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan serta intervensi yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup pasien paliatif. Pengkajian ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien secara dini sehingga intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi individu pasien. Proses ini juga membantu dalam menentukan prioritas perawatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Rohman et al., 2024) (Fangidae & Yulia, 2023).

2. Mengelola nyeri dan gejala lain

Perawat berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola nyeri serta gejala lain seperti sesak napas, mual, dan kelelahan. Manajemen yang tepat membantu meningkatkan kenyamanan pasien. Manajemen nyeri dan gejala merupakan inti dari perawatan paliatif. Perawat bertanggung jawab dalam memantau, menilai, serta memberikan intervensi untuk mengurangi nyeri, sesak napas, mual, dan gejala lain. Penanganan yang tepat akan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien (Setyowati, 2024)

3. Memberikan dukungan emosional dan spiritual

Perawat berperan dalam memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada pasien dan keluarga, seperti memberikan empati, mendengarkan keluhan, serta membantu pemenuhan kebutuhan religius pasien. Perawat memberikan dukungan psikologis dan spiritual melalui empati, kehadiran terapeutik, serta membantu pasien menjalankan praktik keagamaan sesuai keyakinannya. Dukungan ini merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam perawatan paliatif (Muhammad et al., 2025) (Rosanna et al., 2024).

4. Edukasi pasien dan keluarga

Perawat berperan sebagai edukator dengan memberikan informasi terkait kondisi penyakit, perawatan yang dilakukan, serta cara merawat pasien di rumah. Perawat memberikan edukasi mengenai kondisi penyakit, terapi, serta perawatan lanjutan di rumah agar pasien dan keluarga lebih siap menghadapi proses penyakit. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan keluarga dalam merawat pasien paliatif (Riani et al., 2023)

5. Berkomunikasi secara terapeutik

Komunikasi terapeutik menjadi keterampilan penting dalam perawatan paliatif. Perawat harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan suportif untuk membantu pasien memahami kondisi mereka serta mengurangi kecemasan dan ketakutan. Komunikasi terapeutik membantu pasien mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, serta membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien (Suprayitno & Kafil, 2020).

6. Menjadi advokat bagi pasien

Perawat berfungsi sebagai advokat dengan memperjuangkan hak pasien, termasuk hak mendapatkan perawatan yang layak, informasi yang jelas, dan keputusan yang sesuai dengan nilai serta keinginan pasien. Peran ini penting terutama pada pasien dengan kondisi terminal. Perawat bertindak sebagai advokat dengan melindungi hak pasien, membantu dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya (Qodtamalla et al., 2022).

7. Berkolaborasi dengan tim kesehatan lain

Perawatan paliatif bersifat multidisiplin sehingga perawat harus bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat bekerja sama dengan tim multidisiplin seperti dokter, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan paliatif yang optimal dan terintegrasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi (Ratnasari, Fitriyanti, Saptawati, Yulita Sari, et al., 2023) (Pitri et al., 2019).

F. Ruang Lingkup Keperawatan Paliatif

Ruang lingkup pelayanan paliatif meliputi:

1. Perawatan di rumah sakit

Perawatan paliatif di rumah sakit merupakan pelayanan yang diberikan kepada pasien dengan kondisi serius atau terminal melalui pendekatan multidisiplin. Perawat berperan dalam pengkajian komprehensif, manajemen nyeri, serta dukungan emosional dan spiritual pasien serta keluarga. Pelayanan ini biasanya dilakukan di ruang rawat inap, ICU, maupun instalasi gawat darurat, dengan fokus pada:

- a. Pengendalian gejala (nyeri, sesak, mual),
- b. Dukungan psikologis dan spiritual
- c. Perencanaan perawatan akhir hayat (*end of life care*).

Perawatan paliatif di rumah sakit tidak hanya diberikan pada fase terminal, tetapi sudah dimulai sejak pasien terdiagnosis penyakit kronis untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Khairunisa & Handono, 2024a).

2. Perawatan di rumah (*home care*)

Perawatan paliatif berbasis rumah (*home care*) adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di lingkungan rumahnya dengan melibatkan keluarga sebagai bagian utama dalam perawatan. Pelayanan perawatan di rumah (*home care*) ini bertujuan:

- a. Memberikan kenyamanan pasien di lingkungan familiar
- b. Meningkatkan kualitas hidup
- c. Mengurangi hospitalisasi berulang
- d. Memberdayakan keluarga sebagai caregiver

Perawatan ini terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dampak positif bagi keluarga, terutama pada pasien dengan penyakit kronis seperti kanker atau HIV/AIDS (Lindayani & Maryam, 2017)

3. *Hospice care*

Hospice care merupakan bentuk pelayanan paliatif khusus bagi pasien dengan kondisi terminal yang sudah tidak berfokus pada penyembuhan, tetapi pada kenyamanan dan kualitas hidup. Karakteristik *hospice care* yakni (Susilowati & al, 2026):

- a. Fokus pada kenyamanan (*comfort care*)
- b. Dukungan psikologis, sosial, dan spiritual
- c. Pendampingan menjelang kematian
- d. Dukungan keluarga (*bereavement support*)

Hospice dapat dilakukan di fasilitas khusus atau di rumah, dengan pendekatan holistik terhadap pasien dan keluarga

4. Pelayanan komunitas

Pelayanan paliatif berbasis komunitas dilakukan melalui puskesmas, klinik, atau organisasi masyarakat untuk menjangkau pasien di lingkungan sosialnya. Tujuan utama pelayanan komunitas yakni (Wantiyah & al, 2022):

- a. Memperluas akses pelayanan paliatif
- b. Edukasi masyarakat tentang perawatan paliatif
- c. Dukungan sosial berbasis komunitas
- d. Integrasi layanan (Rumah Sakit-Puskesmas-*Home Care*)

Pendekatan komunitas sangat penting terutama di negara berkembang untuk menjangkau pasien yang tidak memiliki akses ke rumah sakit.

G. Etika dalam Keperawatan Paliatif

Beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan:

1. *Autonomy* (menghormati keputusan pasien)

Prinsip *autonomy* menekankan bahwa pasien memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan terkait perawatan dirinya, termasuk menerima atau menolak tindakan medis. Dalam keperawatan paliatif, prinsip ini sangat penting karena pasien sering menghadapi kondisi terminal sehingga keputusan yang diambil berkaitan dengan kualitas hidup, bukan sekadar penyembuhan. Perawat harus memberikan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap agar pasien dapat membuat keputusan secara sadar (*informed consent*). Selain itu, perawat juga harus menghormati nilai, keyakinan, dan preferensi pasien, termasuk dalam hal perawatan akhir kehidupan (Purwanti, 2019; Siahaan & Purnamawati, 2023)

2. *Beneficence* (memberikan manfaat terbaik)

Prinsip *beneficence* mengharuskan perawat untuk selalu bertindak demi kebaikan pasien dengan memberikan intervensi yang memberikan manfaat

maksimal. Dalam konteks paliatif, manfaat tidak selalu berarti menyembuhkan, tetapi lebih kepada meningkatkan kualitas hidup, mengurangi penderitaan, serta memberikan kenyamanan fisik, psikologis, dan spiritual. Perawat harus mempertimbangkan tindakan yang paling menguntungkan bagi pasien, termasuk manajemen nyeri, dukungan emosional, dan pendampingan keluarga (Beauchamp & Childress, 2019; Nandifa et al., 2019)

3. *Non-maleficence* (tidak merugikan pasien)

Prinsip non-maleficence berarti “tidak membahayakan pasien”. Dalam keperawatan paliatif, prinsip ini menuntut perawat untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini mencakup pencegahan nyeri yang tidak perlu, menghindari prosedur invasif yang tidak memberikan manfaat signifikan, serta memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai standar untuk mencegah cedera atau penderitaan tambahan. Prinsip ini sering berjalan beriringan dengan beneficence dalam menentukan keputusan klinis terbaik (Caryanto & Awaludin, 2024; Kuswati & Awaludin, 2023)

4. *Justice* (keadilan dalam pelayanan)

Prinsip justice menekankan keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Dalam keperawatan paliatif, semua pasien berhak mendapatkan perawatan yang setara, termasuk akses terhadap manajemen nyeri, dukungan psikososial, dan pelayanan akhir hayat yang bermartabat. Perawat harus memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil serta tidak membedakan pasien berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau agama. Prinsip ini juga berkaitan dengan alokasi sumber daya kesehatan yang terbatas secara etis dan proporsional (Nandifa, 2019; Widyawati, 2023)

H. Tantangan dalam Keperawatan Paliatif

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perawatan paliatif menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasinya. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa perawatan paliatif hanya diberikan pada pasien menjelang kematian, sehingga menyebabkan keterlambatan akses layanan. Selain itu, rendahnya literasi kesehatan membuat keluarga tidak memahami cara merawat pasien secara optimal di rumah, termasuk dalam manajemen nyeri dan dukungan psikososial. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup pasien serta meningkatnya beban keluarga dalam merawat pasien paliatif (Sugiyanto et al., 2021).

2. Keterbatasan tenaga terlatih

Keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus dalam perawatan paliatif menjadi tantangan serius, terutama di negara berkembang. Kurangnya pelatihan formal, minimnya kurikulum paliatif dalam pendidikan kesehatan, serta terbatasnya tenaga profesional menyebabkan pelayanan paliatif belum optimal. Hal ini mengakibatkan ketimpangan akses layanan serta rendahnya kualitas perawatan, khususnya dalam aspek manajemen gejala dan dukungan spiritual pasien (Hidayah, 2023).

3. Hambatan budaya dan spiritual

Faktor budaya dan spiritual memiliki pengaruh besar dalam perawatan paliatif, terutama di masyarakat dengan nilai religius yang kuat. Perbedaan keyakinan, norma budaya, serta persepsi terhadap penyakit dan kematian seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan klinis. Misalnya, keluarga cenderung menghindari pembicaraan tentang kematian atau menolak tindakan tertentu karena alasan budaya atau agama. Hal ini dapat menghambat penerapan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien serta mengganggu proses perawatan yang holistik (Ilyas, 2025)

4. Masalah komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga

Komunikasi yang tidak efektif antara tenaga kesehatan dan keluarga merupakan tantangan yang kompleks dalam keperawatan paliatif. Hambatan ini dapat disebabkan oleh rendahnya literasi kesehatan, perbedaan budaya, beban emosional, serta kurangnya keterampilan komunikasi terapeutik dari tenaga kesehatan. Selain itu, keluarga sering mengalami kesulitan memahami informasi medis, terutama terkait prognosis dan keputusan akhir kehidupan. Ketidakjelasan komunikasi ini dapat menyebabkan konflik, kesalahan pengambilan keputusan, serta menurunnya kualitas pelayanan paliatif secara keseluruhan (Pashar et al., 2025).

I. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa keperawatan paliatif merupakan pendekatan asuhan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan serta pengurangan penderitaan secara menyeluruh. Perawatan ini tidak hanya diberikan pada fase akhir kehidupan, tetapi dimulai sejak diagnosis hingga akhir hayat dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Mahasiswa perlu memahami bahwa tujuan utama keperawatan paliatif adalah mengurangi penderitaan pasien secara komprehensif, meningkatkan kualitas hidup, mengelola nyeri dan gejala lain, serta memberikan dukungan psikologis, spiritual, dan sosial kepada pasien maupun keluarga. Selain itu, perawatan paliatif juga membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perawatan serta memberikan dukungan berkelanjutan termasuk pada masa berduka.

Prinsip dasar keperawatan paliatif menekankan penghargaan terhadap kehidupan dan penerimaan kematian sebagai proses alami, tanpa mempercepat maupun menunda kematian secara tidak proporsional. Fokus utama perawatan adalah kenyamanan pasien (comfort care) melalui pendekatan holistik, berpusat pada kebutuhan pasien, serta melibatkan keluarga sebagai bagian dari unit perawatan. Pelayanan dilakukan secara kolaboratif oleh tim multidisiplin untuk memastikan kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal.

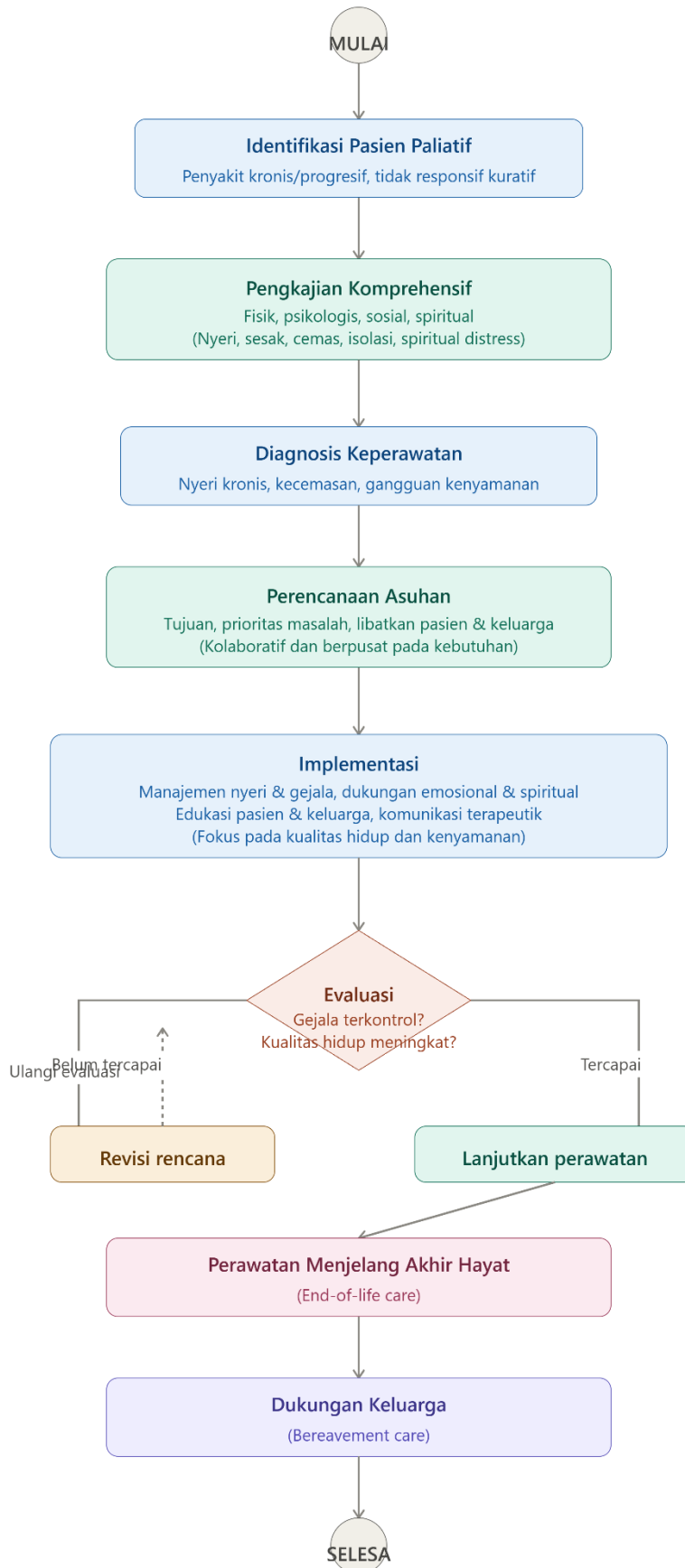
Filosofi perawatan paliatif didasarkan pada nilai kemanusiaan seperti penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity), peningkatan kualitas hidup (quality of life), perawatan menyeluruh (holistic care), pelayanan berpusat pada pasien (patient-centered care), serta kasih sayang (compassion). Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam memberikan asuhan yang bermakna, bermartabat, dan berempati kepada pasien dan keluarga.

Dalam praktiknya, mahasiswa harus memahami peran perawat yang sangat penting dalam keperawatan paliatif, mulai dari melakukan pengkajian komprehensif, mengelola nyeri dan gejala, memberikan dukungan emosional dan spiritual, melakukan edukasi, berkomunikasi secara terapeutik, hingga menjadi advokat bagi pasien. Selain itu, perawat juga harus mampu bekerja sama dengan tim kesehatan lain untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ruang lingkup keperawatan paliatif meliputi pelayanan di rumah sakit, perawatan di rumah (home care), hospice care, serta pelayanan berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan paliatif dapat diberikan di berbagai setting dengan tujuan utama meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien.

Mahasiswa juga perlu memahami aspek etika dalam keperawatan paliatif seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Selain itu, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perawatan paliatif, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga terlatih, hambatan budaya dan spiritual, serta masalah komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan.

Dengan demikian, inti pembelajaran pada bab ini adalah bahwa keperawatan paliatif harus dilakukan secara holistik, berpusat pada pasien, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta etika. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep dan prinsip dasar, tetapi juga mampu menerapkan peran perawat secara profesional, bekerja dalam tim multidisiplin, serta memberikan asuhan yang empatik, bermartabat, dan berfokus pada kualitas hidup pasien dan keluarga.



Gambar 1. 1 flowchart visual lengkap alur asuhan perawatan paliatif

J. Latihan Soal

Soal 1

Seorang pasien baru didiagnosis kanker stadium lanjut dan masih menjalani terapi untuk mengendalikan penyakit. Pasien mengalami nyeri, kecemasan, dan kesulitan tidur. Keluarga beranggapan bahwa perawatan paliatif baru dapat diberikan ketika pasien sudah mendekati kematian. Penjelasan perawat yang paling tepat adalah

- A. perawatan paliatif hanya diberikan setelah seluruh terapi dihentikan
- B. perawatan paliatif hanya diberikan pada pasien yang tidak sadar
- C. perawatan paliatif dapat dimulai sejak diagnosis penyakit yang mengancam jiwa
- D. perawatan paliatif hanya berfokus pada pengobatan nyeri fisik
- E. perawatan paliatif baru diberikan ketika pasien dirawat di hospice

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Perawatan sejak diagnosis hingga akhir hayat.

Pembahasan:

Keperawatan paliatif tidak hanya diberikan pada fase terminal atau saat pasien menjelang kematian. Pendekatan ini dapat dimulai sejak pasien didiagnosis mengalami penyakit yang mengancam jiwa dan dilaksanakan bersamaan dengan terapi lain yang masih diberikan.

Tujuannya adalah mencegah dan mengurangi penderitaan melalui pengkajian serta pengelolaan masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan memulai perawatan sejak dini, kenyamanan dan kualitas hidup pasien serta keluarganya dapat dipertahankan sepanjang perjalanan penyakit.

Soal 2

Seorang pasien paliatif mengalami nyeri, sesak napas, kecemasan, konflik dengan keluarga, dan merasa kehilangan makna hidup. Perawat tidak hanya mengelola nyeri dan sesak, tetapi juga memberikan dukungan emosional, memfasilitasi komunikasi keluarga, serta membantu pasien memperoleh pendampingan spiritual. Prinsip keperawatan paliatif yang diterapkan adalah

- A. perawatan kuratif
- B. pendekatan holistik
- C. tindakan diagnostik
- D. pembatasan pelayanan
- E. perawatan administratif

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: Bio-psiko-sosial-spiritual.

Pembahasan:

Pendekatan holistik berarti pasien dipandang sebagai individu utuh yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pada pasien paliatif, penderitaan tidak selalu hanya berasal dari gejala fisik, tetapi juga dapat berkaitan dengan kecemasan, perubahan peran sosial, konflik keluarga, atau krisis spiritual. Oleh karena itu, asuhan tidak cukup hanya dengan mengurangi nyeri dan sesak. Perawat perlu melakukan pengkajian menyeluruh dan melibatkan anggota tim lain sesuai kebutuhan agar seluruh dimensi kehidupan pasien dapat ditangani secara komprehensif.

Soal 3

Seorang pasien dengan penyakit terminal menolak tindakan invasif setelah memperoleh penjelasan yang jelas mengenai manfaat, risiko, dan alternatif tindakan. Keluarga meminta perawat tetap melakukan tindakan tersebut karena merasa lebih mengetahui kebutuhan pasien. Sikap perawat yang paling sesuai dengan prinsip etika adalah

- A. mengikuti keinginan keluarga tanpa mempertimbangkan pasien
- B. menunda penyampaian informasi agar pasien tidak cemas
- C. menghormati keputusan pasien setelah memastikan pemahamannya
- D. menyerahkan seluruh keputusan kepada tenaga kesehatan
- E. melakukan tindakan tanpa persetujuan karena kondisi pasien terminal

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: *Autonomy* dan *informed consent*.

Pembahasan:

Prinsip *autonomy* menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk menentukan pilihan terkait perawatan dirinya, termasuk menerima atau menolak tindakan. Keputusan tersebut harus dibuat setelah pasien memperoleh informasi yang jelas, jujur, dan lengkap.

Perawat berkewajiban memastikan pasien memahami konsekuensi dari pilihannya serta tidak mengalami tekanan dari pihak lain. Nilai, keyakinan, dan preferensi pasien tetap harus dihormati, terutama dalam keputusan sensitif mengenai perawatan akhir kehidupan.

Soal 4

Seorang pasien dengan kondisi terminal tidak lagi menjalani terapi yang berorientasi pada penyembuhan. Pelayanan difokuskan pada kenyamanan, pengendalian gejala, pendampingan menjelang kematian, serta dukungan berduka bagi keluarga. Jenis pelayanan yang paling sesuai adalah

- A. pelayanan rehabilitasi
- B. pelayanan promotif
- C. *hospice care*
- D. pelayanan rawat jalan umum
- E. pelayanan diagnostik

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Kenyamanan pada kondisi terminal.

Pembahasan:

Hospice care merupakan bentuk pelayanan paliatif khusus bagi pasien dengan kondisi terminal yang tidak lagi berfokus pada penyembuhan. Pelayanan diarahkan pada *comfort care*, pengendalian gejala, pemenuhan kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual, serta pendampingan menjelang kematian.

Dukungan juga diberikan kepada keluarga, termasuk persiapan menghadapi kematian pasien dan pendampingan pada masa berduka. Pelayanan hospice dapat diberikan di fasilitas khusus maupun di rumah, bergantung pada kondisi dan kebutuhan pasien.

Soal 5

Seorang pasien paliatif mengalami sesak napas, mual, kecemasan, dan masalah pemenuhan nutrisi. Perawat bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan untuk menyusun rencana perawatan. Tujuan utama kolaborasi tersebut adalah

- A. memindahkan tanggung jawab perawat kepada profesi lain
- B. mengurangi keterlibatan pasien dalam perawatan
- C. memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif dan terintegrasi
- D. mempercepat penghentian seluruh tindakan perawatan
- E. membatasi dukungan keluarga kepada pasien

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Tim multidisiplin.

Pembahasan:

Pasien paliatif sering memiliki kebutuhan yang kompleks sehingga tidak dapat ditangani secara optimal oleh satu profesi. Dokter dapat membantu pengelolaan medis, ahli gizi menangani kebutuhan nutrisi, psikolog memberikan dukungan

psikologis, pekerja sosial membantu masalah sosial, sedangkan rohaniawan mendukung kebutuhan spiritual.

Referensi

- Astuti, N. L. S., Saifudin, I. M. M. Y., & Wisnawa, I. N. D. (2023). Pemberian Perawatan Paliatif pada Pasien End of Life di IGD. *Jurnal Keperawatan*, 16(2). <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v16i2.1553>
- Astuti, N. L. S., Saifudin, I. M. M. Y., Wisnawa, I. N. D., & Ulan Dewi, I. D. A. N. M. (2023). Pemberian Perawatan Palliative pada Pasien End of Life di IGD: Scoping Review. *Jurnal Keperawatan*, 16(2). <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v16i2.1553>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Caryanto, V. B. C., & Awaludin, S. (2024). Analisis Konsep Non Maleficence pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Diabetes Mellitus. *Journal of Nursing Practice and Education*. <https://doi.org/10.34305/jnpe.v5i1.1441>
- Chochinov, H. M. (2006). Dying, Dignity, and New Horizons in Palliative Care. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 56(2), 84–103. <https://doi.org/10.3322/canjclin.56.2.84>
- Connor, S. R., & Sepulveda Bermedo, M. C. (2018). *Global Atlas of Palliative Care at the End of Life*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514637>
- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). The Values and Value of Patient-Centered Care. *Annals of Family Medicine*, 9(2), 100–103. <https://doi.org/10.1370/afm.1239>
- Fangidae, E., & Yulia, S. (2023). Hambatan Perawat dalam Memberikan Perawatan Paliatif. *Jurnal Keperawatan Merdeka*, 2(2). <https://doi.org/10.36086/jkm.v2i2.1432>
- Felenditi, D. (2013). Terapi Paliatif dalam Profesi Kedokteran. *Jurnal Biomedik*, 5(1). <https://doi.org/10.35790/jbm.5.1.2013.2041>
- Ferrell, B., & Coyle, N. (2015). *Oxford Textbook of Palliative Nursing*. Oxford University Press. <https://global.oup.com>
- Hidayah, N. (2023). Gambaran Pelayanan Paliatif di Indonesia: Systematic Review. *Jurnal Vokasi Kesehatan*. <https://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JVK/article/view/1481>
- Ilyas, M. (2025). Komunikasi Perawat–Keluarga pada Perawatan Paliatif: Pengaruh Norma Religius dan Struktur Keluarga Terhadap Keputusan Klinis. *Journal of Health Quality Development*. <https://doi.org/10.51577/jhq.v5i1.796>
- Khairunisa, F., & Handono, N. P. (2024a). Pengkajian Perawatan Paliatif dan End of Life pada Pasien CHF: Literature Review. *Jurnal Keperawatan GSH*, 13(2). <https://doi.org/10.56840/jkgsh.v13i2.128>

- Khairunisa, F., & Handono, N. P. (2024b). Pengkajian Perawatan Paliatif dan End of Life pada Pasien CHF. *Jurnal Keperawatan GSH*, 13(2). <https://doi.org/10.56840/jkgsh.v13i2.128>
- Khairunisa, F., & Handono, N. P. (2024c). Pengkajian Perawatan Paliatif dan End of Life pada Pasien Congestive Heart Failure: Literature Review. *Jurnal Keperawatan GSH*, 13(2). <https://doi.org/10.56840/jkgsh.v13i2.128>
- Kuswati, A., & Awaludin, S. (2023). Non Malefficiency pada Pasien Hipertensi: Analisis Konsep. *Jurnal Keperawatan Mersi*. <https://doi.org/10.31983/jkm.v13i1.10631>
- Lindayani, L., & Maryam, N. N. A. (2017). Efektivitas Palliative Home Care terhadap Kualitas Hidup Pasien. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/jkp.v5i1.347>
- Listyarini, A. D., Nawanda, A. N., & Musthofiah, A. (2024). Family Caregiver of Palliative Care Patient: Literature Review. *Jurnal Profesi Keperawatan*, 11(1). <https://jprokep.jurnal.centamaku.ac.id/index.php/jpk/article/view/211>
- Ludfiani, D., & Suhartini, T. (2024). Hubungan Penatalaksanaan Perawatan Paliatif dengan Kualitas Hidup Pasien. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 9(1), 45–52. <https://journal.um-surabaya.ac.id/JKM/article/view/20390>
- Malaha, N., & al, et. (2025). Kontribusi dan Tugas Utama Perawatan Paliatif dalam Perawatan pada Pasien dengan Penyakit Tidak Dapat Disembuhkan. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5094–5099. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2756>
- Mamnua, M., & Trihidayati, N. (2024). Palliative Care Pada Pasien Skizofrenia: A Literatur Review. *Jurnal Berita Ilmu Keperawatan*, 15(1). <https://doi.org/10.23917/bik.v15i1.16362>
- Mediani, H. S., Hendrawati, S., & Riyanti, S. (2024). Healthcare Professionals' Experiences in Providing Palliative Care. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 123–135. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S486021>
- Muhammad, F. P., Ismawati, & Nusi, T. (2025). Hubungan Peran Perawat sebagai Care Giver dengan Pemenuhan Kebutuhan Religi. *Inovasi Kesehatan Global*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/ikg.v2i2.1648>
- Nandifa, V. N. P. (2019). Moral Reasoning and Ethical Principles in Medical Practice. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*. <https://doi.org/10.22146/jpki.44511>
- Nandifa, V. N. P., Jena, Y., & Joewana, S. (2019). Beneficence is the Highest Moral Imperative of a Doctor Dealing with the Poor Quality of Patient Autonomy. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*. <https://doi.org/10.22146/jpki.44511>

- Organization, W. H. (2015). *WHO Definition of Palliative Care*. World Health Organization. <https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>
- Organization, W. H. (2020). *Palliative Care*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- Pashar, I., Ansari, M. R. R., & Wildan, M. (2025). Mengatasi Hambatan Komunikasi dalam Perawatan Paliatif: Perspektif Pasien, Keluarga, dan Tenaga Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i3.46716>
- Pitri, A. D., Ismail, S., & Erawati, M. (2019). Eksplorasi Peran Perawat dan Ahli Gizi dalam Pemberian Nutrisi pada Pasien. *Jurnal Perawat Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.32584/jpi.v3i2.316>
- Purwanti. (2019). Gambaran Tingkat Penerapan Prinsip Etik Keperawatan di Ruang Rawat Inap. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*. <https://ejournal.unimugo.ac.id/JIKK/article/view/426>
- Qodtamalla, S., Melastuti, E., & Amal, A. I. (2022). Gambaran Pengetahuan dan Peran Perawat dalam Perawatan Paliatif. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/24996>
- Ratnasari, Fitriyanti, D., Saptawati, T., Sari, R. Y., & Sa'adah, A. (2023). Perawatan Palliative Berbasis Kolaborasi Tim. *Jurnal Pengabdian Perawat*, 2(2). <https://doi.org/10.32584/jpp.v2i2.2395>
- Ratnasari, Fitriyanti, D., Saptawati, T., Yulita Sari, R., & Sa'adah, A. (2023). Perawatan Paliatif Berbasis Kolaborasi Tim. *Jurnal Pengabdian Perawat*, 2(2). <https://doi.org/10.32584/jpp.v2i2.2395>
- Riani, S., Ismonah, & Gloria, F. (2023). Optimalisasi Peran Perawat Melakukan Screening Palliative Care. *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i2.305>
- Rohman, A. A., Permana, I., Febrianti, I., & Melia, M. (2024). Optimalisasi Peran Perawat dalam Melakukan Screening Palliative Care. *Kolaborasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 310–314. <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v4i4.394>
- Rosa, E. M., Rochmawati, E., & Sulistyowati, E. (2020). Implementasi Patient Centered Care dalam Palliative Care. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 150–158. <https://doi.org/10.30651/aks.v4i2.2903>
- Rosanna, R., Agusthia, M., & Noer, R. M. (2024). Peran Perawat dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan*, 4(1).
- Sari, E., Dewi, N. R., & Immawati. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Spiritual pada Pasien Paliatif. *Jurnal Cendikia Muda*, 4(2). <https://jurnal.akperdharmawacana.ac.id/index.php/JWC/article/view/621>

- Saunders, C. (2003). *Watch with Me: Inspirational Stories of Caregiving*. Observatory Publications.
- Setyowati, E. R. (2023). Perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan paliatif. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada*, 15(2). <https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i02.1205>
- Setyowati, E. R. (2024). Perilaku Perawat dalam Memberikan Asuhan Keperawatan Paliatif pada Pasien Kanker. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada*, 15(2). <https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i02.1205>
- Shatri, H., & Sampurna, B. (2020). Advanced Directives pada Perawatan Paliatif. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(2), 125–132. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i2.315>
- Siahaan, L., & Purnamawati, R. S. (2023). *Dilema Etika Berbuat Baik (Beneficience) dan Menghormati Keputusan Klinis Pasien (Autonomy)*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/232351>
- Sinclair, S., Norris, J. M., & McConnell, S. J. (2016). Compassion: A Scoping Review of the Healthcare Literature. *BMC Palliative Care*, 15(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s12904-016-0080-0>
- Sugiyanto, E. P., Prasetyo, C. H., & Pramono, W. H. (2021). Upaya Peningkatan Kemampuan Perawatan Keluarga Paliatif melalui Pendidikan Kesehatan. *Jurnal Peduli Masyarakat*. <https://doi.org/10.37287/jpm.v3i3.592>
- Suprayitno, E., & Kafil, R. F. (2020). Sikap Perawat dalam Memberikan Asuhan Keperawatan pada Pasien Paliatif. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 16(2), 135–146. <https://doi.org/10.31101/jkk.1782>
- Susilowati, Y. A., & al, et. (2026). Pengembangan Model Hospice Care Berbasis Perguruan Tinggi. *Jurnal Ners*, 10(1). <https://doi.org/10.31004/jn.v10i1.53627>
- Temel, J. S., Greer, J. A., & Muzikansky, A. (2010). Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. *New England Journal of Medicine*, 363(8), 733–742. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1000678>
- Wantiyah, W., & al, et. (2022). Palliative Care dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia. *The Indonesian Journal of Health Science*. <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/TIJHS/article/view/8286>
- Widyawati. (2023). Implementasi Prinsip Etik Keperawatan dalam Asuhan Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Cerebral Medika*. <https://doi.org/10.53475/jicm.v5i1.144>

BAB 2

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PALIATIF DAN PENILAIAN KOMPREHENSIF

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dan filosofi keperawatan paliatif, pendekatan holistik, serta prinsip kualitas hidup dan patient-centered care.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan penilaian paliatif komprehensif (fisik, psikologis, sosial, spiritual) dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang dan melaksanakan manajemen gejala utama (nyeri, sesak, GI, kelelahan, distres psikologis) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) serta kolaborasi interprofesional dan advokasi pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif termasuk akhir hayat.	CPMK-6; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, discharge/home care planning, serta dukungan caregiver dan bereavement berbasis kebutuhan.	CPMK-7; CPMK-6; CPMK-5

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan paliatif, filosofi perawatan, prinsip kualitas hidup, dan ruang lingkup layanan paliatif.
CPMK-2	Melakukan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif (fisik–psikologis–sosial–spiritual) serta menetapkan prioritas kebutuhan.
CPMK-3	Menerapkan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) dan pengambilan keputusan bersama pasien–keluarga secara etis.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan manajemen nyeri dan gejala utama paliatif berbasis bukti, termasuk monitoring efektivitas dan efek samping.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan akhir hayat dan dukungan keluarga/caregiver (termasuk bereavement care) dengan fokus kenyamanan dan keselamatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan spiritual-budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (home care/rujukan).
CPMK-7	Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta refleksi perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Identifikasi Kebutuhan Paliatif dan Penilaian Komprehensif	2.1 Melakukan skrining kebutuhan paliatif dan menetapkan prioritas masalah berdasarkan tingkat beban gejala.	2.2 Menyusun penilaian komprehensif bio-psiko-sosio-spiritual yang terdokumentasi.	CPMK-2	CPMK-7; CPMK-3

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE penilaian paliatif komprehensif + checklist	Kelengkapan penilaian (fisik-psiko-sosio-spiritual) dan ketepatan penetapan prioritas kebutuhan (checklist).	15	Checklist OSCE; lembar penilaian
CPMK-3	Simulasi komunikasi (kabar sulit/ACP) + rubrik	Kualitas komunikasi terstruktur dan kelengkapan dokumen tujuan perawatan/ACP (skor rubrik).	15	Video/rekaman; dokumen ACP ringkas
CPMK-7	Portofolio laporan kasus & rencana tindak lanjut/home care	Kelengkapan evaluasi luaran berbasis indikator dan kualitas rencana tindak lanjut (discharge/home care) terukur.	15	Laporan kasus; rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep paliatif (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan prinsip paliatif pada skenario	Keliru/berisiko	Cukup tepat; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat & komprehensif

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan penilaian komprehensif (checklist)	≤60% komponen terpenuhi; data penting hilang	61–75% terpenuhi; masih ada kekurangan bermakna	76–90% terpenuhi; kekurangan minor	>90% terpenuhi; sangat sistematis
2.2 Ketepatan penetapan prioritas kebutuhan	Prioritas tidak sesuai beban gejala	Cukup sesuai; masih ada ketidaktepatan	Sesuai; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & terdokumentasi

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kualitas komunikasi kabar sulit/ACP	Tidak terstruktur; kurang empatik	Terstruktur sebagian; empati terbatas	Terstruktur; empatik; jelas	Sangat terstruktur; empati tinggi; responsif terhadap nilai pasien
3.2 Kelengkapan tujuan perawatan/ACP terdokumentasi	Tidak lengkap; tidak dapat ditindaklanjuti	Cukup lengkap; masih umum	Lengkap; tujuan spesifik	Sangat lengkap; tujuan sangat spesifik & terukur + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan penilaian gejala & target (nyeri/sesak/GI)	Penilaian tidak tepat; tanpa target	Penilaian cukup; target kurang jelas	Penilaian tepat; target jelas	Penilaian sangat tepat; target spesifik dan realistis
4.2 Ketepatan intervensi & evaluasi respons	Intervensi tidak sesuai; evaluasi tidak ada	Intervensi cukup; evaluasi terbatas	Intervensi sesuai; evaluasi jelas	Intervensi sangat sesuai; evaluasi komprehensif & terdokumentasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan comfort care & keselamatan tindakan	Tidak sesuai tujuan perawatan; risiko tinggi	Cukup sesuai; ada kekurangan bermakna	Sesuai; aman; konsisten	Sangat sesuai; sangat aman; antisipatif komplikasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Kualitas dukungan keluarga & bereavement readiness	Tidak responsif; tanpa rencana	Respons ada; rencana umum	Respons baik; rencana tindak lanjut jelas	Dukungan sangat baik; rencana bereavement sangat jelas & terukur

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pemetaan kebutuhan spiritual-budaya & preferensi	Tidak teridentifikasi	Teridentifikasi sebagian	Teridentifikasi jelas	Sangat jelas; mempertimbangkan nilai/ritual kunci
6.2 Kualitas rencana kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak ada rencana; peran tidak jelas	Ada rencana; koordinasi kurang runtut	Koordinasi jelas; indikator tindak lanjut ada	Koordinasi sangat efektif; indikator komprehensif & keberlanjutan kuat

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran paliatif berbasis indikator	Tidak menggunakan indikator	Indikator terbatas; analisis minim	Indikator memadai; analisis jelas	Indikator komprehensif; analisis kritis & akurat
7.2 Kualitas rencana tindak lanjut/home care	Tidak spesifik; tidak terukur	Cukup spesifik; sebagian terukur	Spesifik; terukur; realistis	Sangat spesifik, terukur, realistis; koordinasi layanan jelas

A. Definisi dan Filosofi Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif didefinisikan oleh World Health Organization (World Health Organization, 2020) sebagai pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien (dewasa dan anak-anak) dan keluarga mereka yang menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa. Perawatan ini dilakukan melalui pencegahan dan peredaan penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang tepat, dan penanganan nyeri serta masalah fisik, psikososial, dan spiritual lainnya. Filosofi yang mendasari perawatan paliatif adalah:

1. Penghargaan terhadap martabat manusia — setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan martabat, termasuk pada akhir kehidupannya

2. Pendekatan holistik — manusia dipandang sebagai makhluk bio-psiko-sosio-spiritual yang utuh
3. Berpusat pada pasien dan keluarga — pasien dan keluarga adalah pusat dari setiap keputusan perawatan
4. Kualitas hidup sebagai tujuan utama — bukan sekadar memperpanjang hidup

Perawatan paliatif tidak hanya untuk pasien kanker. Berdasarkan berbagai referensi internasional (Pérez-Cruz et al., 2023; Radbruch et al., 2020; World Health Organization, 2020) perawatan paliatif juga diindikasikan untuk **penyakit** tidak menular (PTM) kronis progresif, seperti:

Tabel 2. 1 Penyakit tidak menular dan kondisi paliatif

Penyakit	Contoh Kondisi Paliatif
Penyakit Kardiovaskular	Gagal jantung kongestif stadium akhir (NYHA III-IV), kardiomiopati, penyakit jantung koroner lanjut
Penyakit Respirasi	PPOK berat (GOLD stage III-IV), fibrosis paru idiopatik, penyakit paru interstisial
Penyakit Ginjal	Gagal ginjal kronik stadium 5 (CKD stage V) yang tidak menjalani dialisis atau memilih terapi konservatif
Penyakit Neurologis	Demensia (Alzheimer, vaskular), Parkinson stadium lanjut, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), stroke berat dengan defisit permanen
Penyakit Hati	Sirosis hepatitis dekompensata, gagal hati stadium akhir
Penyakit Metabolik	Diabetes melitus dengan komplikasi berat (neuropati, gangren, gagal ginjal)
HIV/AIDS	Stadium lanjut dengan infeksi oportunistik
Penyakit Reumatologi	Lupus eritematosus sistemik berat, skleroderma sistemik

PTM memerlukan perawatan paliatif (Pérez-Cruz et al., 2023) dikarenakan pasien dengan PTM stadium lanjut mengalami:

- Gejala fisik yang tidak terkendali (nyeri, sesak napas, kelelahan kronis)
- Penurunan status fungsional progresif
- Beban psikologis (kecemasan, depresi, ketakutan akan kematian)
- Beban sosial dan finansial yang signifikan
- Kebutuhan spiritual yang semakin meningkat menjelang akhir kehidupan

B. Perbedaan Perawatan Paliatif dengan Perawatan Kuratif

Tabel 2. 2 Perbedaan perawatan paliatif dan kuratif

Aspek	Perawatan Kuratif	Perawatan Paliatif
Tujuan utama	Menyembuhkan penyakit	Meningkatkan kualitas hidup
Waktu pemberian	Fase awal hingga stabil	Diberikan sejak diagnosis, bersamaan dengan kuratif
Fokus	Penyakit dan organ yang sakit	Manusia secara utuh (bio-psiko-sosio-spiritual)
Pendekatan	Spesifik penyakit	Holistik, berpusat pada pasien dan keluarga
Tim	Dominan medis	Interdisiplin (dokter, perawat, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, ahli gizi)
Contoh penyakit	Kanker stadium awal, infeksi akut	Kanker stadium lanjut, gagal jantung, PPOK berat, demensia, gagal ginjal

Catatan Penting: Perawatan paliatif bukan berarti menyerah atau menghentikan pengobatan kuratif. Keduanya dapat diberikan secara bersamaan (integrated palliative care). Bahkan, perawatan paliatif dianjurkan sejak diagnosis ditegakkan, bukan hanya pada fase terminal.

C. Konsep "Total Pain" (Cicely Saunders)

Dame Cicely Saunders, pendiri gerakan hospice modern, memperkenalkan konsep "Total Pain" yang menjadi fondasi penilaian komprehensif dalam perawatan paliatif. Konsep ini menekankan bahwa penderitaan pasien tidak hanya bersumber dari gejala fisik, tetapi juga dari aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang saling terkait (Wood, 2024).



Gambar 2. 1 Diagram Total Pain

D. Indikasi dan Kriteria Rujukan Perawatan Paliatif

Indikasi Perawatan Paliatif:

Perawatan paliatif diindikasikan untuk pasien dengan:

1. Penyakit yang mengancam jiwa dengan prognosis terbatas (kanker stadium lanjut, gagal jantung stadium akhir, gagal ginjal kronik stadium 5, PPOK berat, demensia lanjut, penyakit neuromuskular progresif)
2. Gejala yang tidak terkontrol (nyeri berat, sesak napas, mual-muntah yang mengganggu, kejang berulang, fatigue berat)
3. Kebutuhan psikososial dan spiritual yang signifikan pada pasien dan keluarga
4. Penurunan status fungsional yang progresif (skor PPS menurun dalam 6 bulan terakhir)
5. Kunjungan rumah sakit berulang (≥ 2 kali dalam 6 bulan)
6. Transisi perawatan dari kuratif ke paliatif

Alat Bantu Identifikasi dengan SPICT (Supportive and Palliative Care Indicators Tool)

SPICT (Liao et al., 2024) membantu mengidentifikasi pasien dengan penyakit yang memburuk dan berisiko mengalami kematian dalam 6-12 bulan. Komponen SPICT meliputi:

Tabel 2. 3 Komponen dan indikator dalam identifikasi Palliative

Komponen	Indikator
Pertanyaan umum	Apakah pasien memiliki penyakit yang mengancam jiwa? Apakah kondisi memburuk?
Indikator klinis umum	Penurunan berat badan >10% dalam 6 bulan, PPS < 70%, kunjungan UGD/rawat inap berulang
Indikator spesifik	Tergantung penyakit: kanker lanjut, gagal jantung NYHA III-IV, PPOK GOLD III-IV, CKD stadium V, demensia berat, dll

NECPAL (NECesidades PALiativas) menggunakan pendekatan "surprise question" : "Apakah Anda akan terkejut jika pasien ini meninggal dalam 12 bulan ke depan?" Jika jawaban adalah "Tidak akan terkejut", maka pasien memiliki risiko tinggi dan perlu dilakukan penilaian paliatif lebih lanjut.

E. Instrumen Penilaian Paliatif

1. ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)

ESAS adalah instrumen yang paling umum digunakan untuk menilai intensitas 9 gejala umum pada pasien paliatif (Donlan et al., 2024) :

Tabel 2. 4 ESAS

Gejala	Skala (0-10)	Keterangan
Nyeri	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = tidak ada nyeri, 10 = nyeri terberat
Kelelahan (fatigue)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = tidak lelah, 10 = sangat lelah
Mual	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = tidak mual, 10 = mual terberat
Depresi	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = tidak depresi, 10 = depresi berat
Kecemasan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = tidak cemas, 10 = sangat cemas
Mengantuk	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = tidak mengantuk, 10 = sangat mengantuk
Sesak napas	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = tidak sesak, 10 = sesak terberat
Nafsu makan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = nafsu makan baik, 10 = tidak ada nafsu makan
Kesejahteraan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	0 = sangat baik, 10 = sangat buruk

Interpretasi Skor ESAS:

- 0 = tidak ada gejala
- 1-3 = gejala ringan
- 4-6 = gejala sedang

- 7-10 = gejala berat

2. PPS (Palliative Performance Scale)

PPS mengukur status fungsional pasien paliatif dengan skala 0-100% (Bischoff et al., 2024):

Tabel 2. 5 PPS

Skor PPS	Status Fungsional	Interpretasi
100-80%	Ambulasinya baik, aktivitas normal	Pasien masih mandiri
70-50%	Ambulasinya berkurang, membutuhkan bantuan	Pasien mulai membutuhkan bantuan
40-20%	Hingga mampu duduk/berbaring	Perawatan intensif, total care
10-0%	Total bedrest	Menjelang ajal

Penurunan skor PPS > 10-20% dalam 3-6 bulan merupakan indikator prognosis memburuk dan kebutuhan paliatif semakin meningkat.

F. Penilaian Komprehensif Kebutuhan Paliatif (Bio-Psiko-Sosio-Spiritual)

1. Penilaian Fisik (Bio)

Tabel 2. 6 Penilaian Fisik

Gejala	Aspek yang Dikaji	Instrumen
Nyeri	Lokasi, intensitas (0-10), karakteristik, faktor pencetus/peredaan	NRS, VAS, Faces Pain Scale
Sesak napas	Frekuensi, faktor pencetus, posisi nyaman, saturasi	Borg Scale, MRC Dyspnea Scale
Kelelahan	Tingkat kelelahan (0-10), pola istirahat, dampak aktivitas (Donlan et al., 2024)	ESAS-fatigue, FACIT-Fatigue
Mual/muntah	Frekuensi, faktor pencetus, efektivitas antiemetik	ESAS-mual
Nutrisi	Berat badan (penurunan >10% dalam 6 bulan), asupan makan	MUST (Malnutrition)

		Universal Screening Tool)
Eliminasi	Frekuensi BAB/BAK, konstipasi, diare, inkontinensia	Bristol Stool Scale
Tidur	Pola tidur, insomnia, sedasi akibat obat	PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)

2. Penilaian Psikologis (Psiko)

Tabel 2. 7 Penilaian psikologis

Aspek	Yang Dikaji	Instrumen
Kecemasan	Tingkat kecemasan, faktor pemicu, manifestasi fisik/psikologis (Lopes et al., 2025)	HADS-A
Depresi	Gejala depresi, anhedonia, perasaan putus asa, risiko bunuh diri	HADS-D, PHQ-9
Ketakutan	Ketakutan akan kematian, rasa sakit, menjadi beban	-
Koping	Mekanisme koping, efektivitas, sumber kekuatan	Brief COPE

3. Penilaian Sosial (Sosial)

Tabel 2. 8 Penilaian Sosial

Aspek	Yang Dikaji
Dukungan keluarga	Keberadaan keluarga, keterlibatan, dinamika, kesiapan merawat
Dukungan sosial	Dukungan teman, komunitas, kelompok pendukung
Beban finansial	Kemampuan membayar, asuransi, beban ekonomi
Peran sosial	Peran yang ditinggalkan, dampak terhadap identitas
Setting perawatan	Tempat tinggal, akses layanan, kesiapan home care

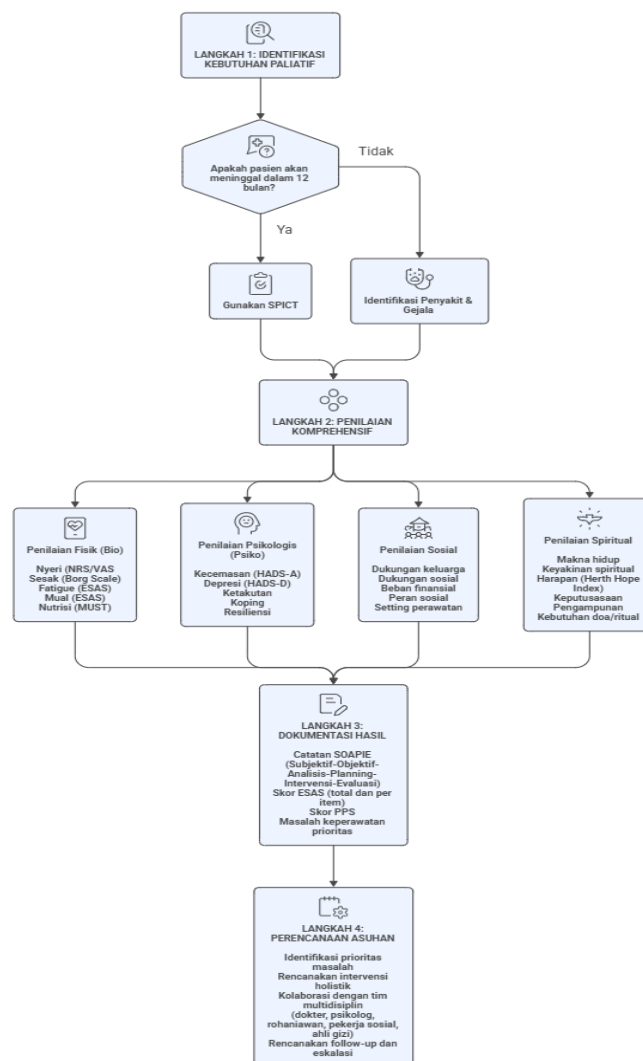
4. Penilaian Spiritual (Spiritual)

Tabel 2. 9 Penilaian Spiritual

Aspek	Yang Dikaji	Instrumen
Makna dan tujuan hidup	Apakah pasien menemukan makna? Ada yang ingin dicapai?	-

Keyakinan spiritual/agama	Agama, praktik spiritual, kebutuhan spiritual	FACIT-Sp
Keputusasaan	Apakah pasien merasa putus asa? Ada keinginan mengakhiri hidup?	-
Pengampunan	Konflik yang belum terselesaikan, kebutuhan memaafkan/diampuni	-
Harapan	Apakah pasien masih memiliki harapan? Harapan seperti apa?(Calderon et al., 2024)	Herth Hope Index (HHI)

G. Alur Penilaian Komprehensif Paliatif



Gambar 2. 2 Diagram Alur penilaian komprehensif paliatif

H. RINGKASAN

Identifikasi Kebutuhan Paliatif dan Penilaian Komprehensif

Bab ini menekankan bahwa perawatan paliatif merupakan pendekatan interdisipliner yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang mengancam jiwa dan keluarga mereka. Perawatan paliatif tidak hanya untuk pasien kanker, tetapi juga untuk penyakit tidak menular (PTM) kronis progresif seperti gagal jantung stadium akhir, PPOK berat, gagal ginjal kronik stadium 5, demensia lanjut, dan penyakit neurologis progresif. Identifikasi kebutuhan paliatif sejak dini merupakan langkah awal yang sangat krusial karena seringkali perawatan paliatif dimulai terlambat, sehingga pasien kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat maksimal dari pendekatan ini.

Mahasiswa perlu memahami bahwa penilaian kebutuhan paliatif tidak hanya berhenti pada gejala fisik, tetapi harus dilanjutkan dengan penilaian kondisi psikologis, sosial, dan spiritual pasien dan keluarga. Pendekatan bio-psiko-sosio-spiritual (Total Pain) menjadi fondasi penilaian komprehensif. Gejala seperti nyeri (skala $>7/10$), sesak napas, kelelahan kronis, penurunan berat badan $>10\%$ dalam 6 bulan, serta tanda-tanda distress psikologis (kecemasan, depresi, ketakutan), distress sosial (dukungan keluarga kurang, beban finansial), dan distress spiritual (keputusasaan, kehilangan makna hidup) merupakan petunjuk penting yang harus diidentifikasi sejak awal.

Alur penilaian paliatif dimulai dari identifikasi kebutuhan menggunakan SPICT atau surprise question, dilanjutkan dengan penilaian komprehensif (bio-psiko-sosio-spiritual), kemudian dokumentasi hasil penilaian, dan terakhir perencanaan asuhan paliatif. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, misalnya nyeri kronis, distress psikologis, defisit dukungan sosial, atau distress spiritual. Setelah masalah prioritas ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan manajemen gejala, dukungan psikososial, pendampingan spiritual, dan edukasi keluarga.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan penilaian holistik yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain melakukan penilaian nyeri dengan instrumen yang sesuai (Faces Pain Scale-Revised pada anak), menggali kebutuhan psikologis dengan pertanyaan terbuka, mengkaji dukungan sosial dan beban finansial keluarga, serta menggali kebutuhan spiritual (keyakinan, harapan, kebutuhan doa). Edukasi kepada orang tua menjadi bagian yang sangat penting, terutama mengenai tanda bahaya (red flags) yang harus segera dilaporkan dan kapan perlu melakukan eskalasi.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perubahan kondisi pasien, misalnya skala nyeri menurun, pasien tampak lebih tenang, keluarga mampu menjelaskan kembali rencana perawatan, dan *red flags* dapat dikenali. Namun, apabila ditemukan *red flags* seperti nyeri hebat tidak terkendali, sesak napas berat, kejang, perubahan kesadaran, ide bunuh diri, distres keluarga berat, atau perdarahan aktif, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab, preceptor, atau dokter sesuai sistem pelayanan.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif harus dilakukan secara holistik, cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu melakukan penilaian holistik, memberikan dukungan psikososial dan spiritual, melakukan edukasi keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Inilah yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada Keperawatan Paliatif.

I. Latihan Soal

Soal 1

Seorang pasien dengan PPOK berat masih menjalani terapi untuk mengendalikan penyakit. Pasien mengalami sesak napas berulang, kelelahan kronis, kecemasan, dan dua kali dirawat di rumah sakit dalam enam bulan terakhir. Keluarga beranggapan bahwa perawatan paliatif baru diberikan ketika seluruh pengobatan dihentikan. Penjelasan perawat yang paling tepat adalah

- A. perawatan paliatif hanya diberikan ketika pasien menjelang ajal
- B. perawatan paliatif diberikan setelah seluruh terapi kuratif dihentikan
- C. perawatan paliatif dapat diberikan sejak diagnosis bersama terapi kuratif
- D. perawatan paliatif hanya ditujukan kepada pasien kanker stadium lanjut
- E. perawatan paliatif hanya diberikan kepada pasien yang tidak sadar

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: *Integrated palliative care.*

Pembahasan:

Perawatan paliatif tidak hanya diberikan pada fase terminal dan tidak berarti menghentikan seluruh pengobatan. Perawatan paliatif dapat dimulai sejak diagnosis penyakit yang mengancam jiwa dan dilaksanakan bersamaan dengan terapi kuratif atau terapi pengendalian penyakit.

Pasien PPOK berat dengan sesak tidak terkendali, penurunan fungsi, dan rawat inap berulang memiliki indikasi untuk menjalani penilaian kebutuhan paliatif. Pendekatan dini dapat membantu mengendalikan gejala sekaligus memberikan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual kepada pasien serta keluarganya.

Soal 2

Seorang pasien kanker stadium lanjut mengalami nyeri hebat. Pasien juga merasa takut menghadapi kematian, kehilangan perannya sebagai pencari nafkah, dan merasa hidupnya tidak lagi bermakna. Konsep yang paling tepat untuk menggambarkan penderitaan pasien tersebut adalah

- A. nyeri neuropatik
- B. nyeri akut
- C. *total pain*
- D. nyeri alih
- E. nyeri nosiseptif

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Pembahasan:

Konsep *total pain* menjelaskan bahwa penderitaan pasien paliatif tidak hanya berasal dari nyeri fisik. Penderitaan juga dapat dipengaruhi oleh kecemasan, ketakutan, masalah hubungan keluarga, hilangnya peran sosial, beban ekonomi, konflik spiritual, dan kehilangan makna hidup.

Pada kasus tersebut, nyeri fisik berkaitan dengan ketakutan akan kematian, kehilangan peran sebagai pencari nafkah, dan distress spiritual. Oleh karena itu, pengkajian dan intervensi harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan bio-psiko-sosio-spiritual.

Soal 3

Seorang perawat sedang mengidentifikasi kebutuhan paliatif pada pasien gagal jantung stadium akhir. Perawat menggunakan pertanyaan, "Apakah Anda akan terkejut jika pasien ini meninggal dalam 12 bulan ke depan?" Perawat menjawab bahwa dirinya tidak akan terkejut. Interpretasi yang paling tepat adalah

- A. pasien tidak memerlukan penilaian lebih lanjut
- B. pasien harus segera menghentikan seluruh terapi
- C. pasien memiliki risiko tinggi dan perlu penilaian paliatif lanjutan
- D. pasien hanya memerlukan pemeriksaan status fisik
- E. pasien sudah pasti meninggal dalam waktu 12 bulan

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: *Surprise question* pada NECPAL.

Pembahasan:

Pertanyaan tersebut merupakan *surprise question* yang digunakan dalam pendekatan NECPAL. Apabila tenaga kesehatan menjawab "tidak akan terkejut", pasien dianggap memiliki risiko tinggi mengalami perburukan atau kematian dalam 12 bulan sehingga memerlukan penilaian paliatif lebih lanjut.

Hasil ini bukan kepastian bahwa pasien akan meninggal dalam waktu 12 bulan. Pertanyaan tersebut berfungsi sebagai alat bantu identifikasi awal untuk menentukan perlunya pengkajian komprehensif, diskusi tujuan perawatan, pengendalian gejala, dan dukungan kepada keluarga.

Soal 4

Hasil penilaian ESAS pada seorang pasien menunjukkan nyeri 8, kelelahan 5, mual 2, dan kecemasan 7. Interpretasi yang paling tepat adalah

- A. nyeri berat, kelelahan sedang, mual ringan, dan kecemasan berat
- B. nyeri sedang, kelelahan berat, mual ringan, dan kecemasan sedang
- C. nyeri berat, kelelahan ringan, mual sedang, dan kecemasan berat
- D. nyeri ringan, kelelahan sedang, mual berat, dan kecemasan sedang
- E. seluruh gejala berada dalam kategori berat

Kunci Jawaban: A

Kata Kunci: Interpretasi skor ESAS.

Pembahasan:

Pada ESAS, skor 0 menunjukkan tidak ada gejala, skor 1–3 menunjukkan gejala ringan, skor 4–6 menunjukkan gejala sedang, sedangkan skor 7–10 menunjukkan gejala berat. Dengan demikian, nyeri 8 dan kecemasan 7 termasuk kategori berat. Kelelahan dengan skor 5 termasuk kategori sedang, sedangkan mual dengan skor 2 termasuk kategori ringan. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan prioritas penanganan, tetapi tetap harus dilengkapi dengan pengkajian penyebab, dampak gejala, dan kebutuhan pasien secara menyeluruh.

Soal 5

Seorang pasien dengan penyakit neurologis progresif memiliki skor PPS 30%. Pasien lebih banyak berbaring, membutuhkan bantuan untuk hampir seluruh aktivitas, mengalami penurunan berat badan, dan keluarganya merasa tidak siap merawat pasien di rumah. Tindakan perawat yang paling tepat adalah

- A. hanya mencatat skor PPS tanpa melakukan pengkajian lain
- B. memusatkan pengkajian pada kemampuan berjalan pasien
- C. melakukan penilaian komprehensif dan menyusun rencana asuhan bersama tim
- D. menunggu sampai skor PPS menjadi 10% sebelum melakukan intervensi
- E. meminta keluarga menentukan seluruh tindakan tanpa penjelasan

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: PPS rendah dan penilaian komprehensif.

Pembahasan:

Skor PPS 30% menunjukkan penurunan status fungsional yang berat. Pasien umumnya lebih banyak duduk atau berbaring dan membutuhkan bantuan intensif

atau perawatan total. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan paliatif yang semakin meningkat.

Referensi

- Bischoff, K. E., Patel, K., Boscardin, W. J., O’Riordan, D. L., Pantilat, S. Z., & Smith, A. K. (2024). Prognoses associated with palliative performance scale scores in modern palliative care practice. *JAMA Network Open*, 7(7), e2420472.
- Calderon, C., Ferrando, P. J., Lorenzo-Seva, U., Ferreira, E., Sorribes, E., Hernández, R., Planellas-Kirchner, I., Mihic-Gongora, L., J. Corral, M., & Jiménez-Fonseca, P. (2024). Psychometric Properties and Measurement Invariance of the Herth Hope Index in Spanish Cancer Patients. *Psicothema*, 36(1), 72–79. <https://doi.org/10.7334/psicothema2023.86>
- Donlan, J., Zeng, C., Indriolo, T., Li, L., Zhu, E., Zhou, J., Pintro, K., Horick, N., Edelen, M., Chung, R. T., El-Jawahri, A., & Ufere, N. N. (2024). The Edmonton Symptom Assessment System is a valid, reliable, and responsive tool to assess symptom burden in decompensated cirrhosis. *Hepatology Communications*, 8(4). <https://doi.org/10.1097/HC9.0000000000000385>
- PPNI. (2016). Standar diagnosis keperawatan Indonesia. *Jakarta: Ppni*.
- PPNI (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan. *Jakarta: Dewan Persatuan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia*.
- Liao, J.-Y., Chang, H.-T., Peng, J.-K., Murray, S. A., Wu, C.-Y., Chang, H.-C., Li, C.-M., Cheng, S.-Y., Tseng, W.-Z., & Hsiung, C. A. (2024). Adaptation of the Taiwan version of the Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT-TW) and its association with six-month mortality: a multi-center validation study in older people. *Healthcare*, 12(21), 2185.
- Lopes, P. P. da S., Schaefer, R., & Scherer, J. N. (2025). Estudo psicométrico da Hospital Anxiety and Depression Scale com profissionais de saúde. *Revista de Saúde Pública*, 59, e238883. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2025059006420>
- Pérez-Cruz, P. E., Undurraga, E., Arreola-Ornelas, H., Corsi, O., Kwete, X.-X. J., Krakauer, E. L., Rosa, W. E., & Knaul, F. M. (2023). Bridging gaps to universal palliative care access in Chile: serious health-related suffering and the cost of expanding the package of care services. *The Lancet Regional Health–Americas*, 19.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan, Edisi 1. *Cetakan II.(Dewan Pengurus PPNI (Ed.)). Dewan Pengurus PPNI*.
- Radbruch, L., De Lima, L., Knaul, F., Wenk, R., Ali, Z., Bhatnagar, S., Blanchard, C., Bruera, E., Buitrago, R., Burla, C., Callaway, M., Munyoro, E. C., Centeno, C., Cleary, J., Connor, S., Davaasuren, O., Downing, J., Foley, K., Goh, C., ... Pastrana, T. (2020). Redefining Palliative Care—A New Consensus-Based

Definition. *Journal of Pain and Symptom Management*, 60(4), 754–764.
<https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.04.027>

Speedie, L., & Middleton, A. (2021). *Wong's Nursing Care of Infants and Children Australia and New Zealand Edition–For Professionals*. Elsevier Health Sciences.

Wood, J. (2024). *Cicely Saunders and Total Pain*. Edinburgh University Press.
<https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781399531061.001.0001>

World Health Organization. (2020). *Palliative care*. 2020. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>

World Health Organization. (2023). *Palliative care for children*. 2023.
<https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/palliative-care-for-children>

BAB 3

MANAJEMEN NYERI DALAM PALIATIF

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dan filosofi keperawatan paliatif, pendekatan holistik, serta prinsip kualitas hidup dan patient-centered care.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan penilaian paliatif komprehensif (fisik, psikologis, sosial, spiritual) dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang dan melaksanakan manajemen gejala utama (nyeri, sesak, GI, kelelahan, distres psikologis) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) serta kolaborasi interprofesional dan advokasi pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif termasuk akhir hayat.	CPMK-6; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, discharge/home care planning, serta dukungan caregiver dan bereavement berbasis kebutuhan.	CPMK-7; CPMK-6; CPMK-5

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan paliatif, filosofi perawatan, prinsip kualitas hidup, dan ruang lingkup layanan paliatif.
CPMK-2	Melakukan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif (fisik–psikologis–sosial–spiritual) serta menetapkan prioritas kebutuhan.
CPMK-3	Menerapkan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) dan pengambilan keputusan bersama pasien–keluarga secara etis.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan manajemen nyeri dan gejala utama paliatif berbasis bukti, termasuk monitoring efektivitas dan efek samping.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan akhir hayat dan dukungan keluarga/caregiver (termasuk bereavement care) dengan fokus kenyamanan dan keselamatan.
CPMK-6	Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan spiritual-budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (home care/rujukan).

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta refleksi perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Manajemen Nyeri dalam Paliatif	3.1 Menilai nyeri menggunakan instrumen terstandar dan menetapkan target penurunan nyeri.	3.2 Melaksanakan rencana manajemen nyeri dan monitoring efek samping secara terukur.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE penilaian paliatif komprehensif + checklist	Kelengkapan penilaian (fisik-psiko-sosio-spiritual) dan ketepatan penetapan prioritas kebutuhan (checklist).	15	Checklist OSCE; lembar penilaian
CPMK-4	Skill station manajemen gejala (nyeri/sesak/GI) + checklist	Ketepatan penilaian gejala, pemilihan intervensi, dan evaluasi respons terukur (persentase langkah benar).	20	Checklist keterampilan; catatan respons
CPMK-7	Portofolio laporan kasus & rencana tindak lanjut/home care	Kelengkapan evaluasi luaran berbasis indikator dan kualitas rencana tindak lanjut (discharge/home care) terukur.	15	Laporan kasus; rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep paliatif (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan prinsip paliatif pada skenario	Keliru/berisiko	Cukup tepat; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat & komprehensif

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan penilaian komprehensif (checklist)	≤60% komponen terpenuhi; data penting hilang	61–75% terpenuhi; masih ada kekurangan bermakna	76–90% terpenuhi; kekurangan minor	>90% terpenuhi; sangat sistematis
2.2 Ketepatan penetapan prioritas kebutuhan	Prioritas tidak sesuai beban gejala	Cukup sesuai; masih ada ketidaktepatan	Sesuai; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & terdokumentasi

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kualitas komunikasi kabar sulit/ACP	Tidak terstruktur; kurang empatik	Terstruktur sebagian; empati terbatas	Terstruktur; empatik; jelas	Sangat terstruktur; empati tinggi; responsif terhadap nilai pasien
3.2 Kelengkapan tujuan perawatan/ACP terdokumentasi	Tidak lengkap; tidak dapat ditindaklanjuti	Cukup lengkap; masih umum	Lengkap; tujuan spesifik	Sangat lengkap; tujuan sangat spesifik & terukur + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan penilaian gejala & target (nyeri/sesak/GI)	Penilaian tidak tepat; tanpa target	Penilaian cukup; target kurang jelas	Penilaian tepat; target jelas	Penilaian sangat tepat; target spesifik dan realistis
4.2 Ketepatan intervensi & evaluasi respons	Intervensi tidak sesuai; evaluasi tidak ada	Intervensi cukup; evaluasi terbatas	Intervensi sesuai; evaluasi jelas	Intervensi sangat sesuai; evaluasi komprehensif & terdokumentasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan comfort care & keselamatan tindakan	Tidak sesuai tujuan perawatan; risiko tinggi	Cukup sesuai; ada kekurangan bermakna	Sesuai; aman; konsisten	Sangat sesuai; sangat aman; antisipatif komplikasi
5.2 Kualitas dukungan keluarga & bereavement readiness	Tidak responsif; tanpa rencana	Respons ada; rencana umum	Respons baik; rencana tindak lanjut jelas	Dukungan sangat baik; rencana bereavement sangat jelas & terukur

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pemetaan kebutuhan spiritual-budaya & preferensi	Tidak teridentifikasi	Teridentifikasi sebagian	Teridentifikasi jelas	Sangat jelas; mempertimbangkan nilai/ritual kunci
6.2 Kualitas rencana kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak ada rencana; peran tidak jelas	Ada rencana; koordinasi kurang runtut	Koordinasi jelas; indikator tindak lanjut ada	Koordinasi sangat efektif; indikator komprehensif & keberlanjutan kuat

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran paliatif berbasis indikator	Tidak menggunakan indikator	Indikator terbatas; analisis minim	Indikator memadai; analisis jelas	Indikator komprehensif; analisis kritis & akurat
7.2 Kualitas rencana tindak lanjut/home care	Tidak spesifik; tidak terukur	Cukup spesifik; sebagian terukur	Spesifik; terukur; realistis	Sangat spesifik, terukur, realistis; koordinasi layanan jelas

A. TEORI DASAR

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Organisasi profesi global seperti *International Association for the Study of Pain* mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman multidimensional yang dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, nyeri tidak hanya dipandang sebagai gejala, tetapi sebagai masalah klinis yang harus ditangani secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (IASP, 2020). Ciri penting dari nyeri meliputi : bersifat subjektif, melibatkan aspek fisik, emosional, dan kognitif, dapat terjadi tanpa bukti kerusakan jaringan. Dalam keperawatan, manajemen nyeri menjadi salah satu kompetensi inti perawat karena nyeri dapat mengganggu mobilitas, tidur, nafsu makan, motivasi, fungsi imun, hingga proses penyembuhan luka. Penanganan nyeri yang tidak adekuat terbukti meningkatkan risiko stres fisiologis, kecemasan, depresi, serta menurunkan kualitas hidup pada pasien dengan penyakit akut, kronis maupun terminal (Lee et al., 2021).

Perkembangan ilmu klinis hingga dekade terakhir menunjukkan bahwa nyeri harus ditangani secara holistik melalui intervensi farmakologi dan non-farmakologi. Pendekatan integratif seperti relaksasi, kompres hangat, teknik pernapasan, mindfulness, pijat ringan, terapi musik, hingga dukungan emosional keluarga telah terbukti efektif dalam mengurangi persepsi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien (Panchal et al., 2022). Hal ini menjadi landasan penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi berbasis bukti dalam praktik sehari-hari. Dengan meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti kanker, diabetes, penyakit muskuloskeletal, serta kasus nyeri pascaoperasi, kebutuhan terhadap manajemen nyeri yang efektif dan humanis semakin tinggi.

Nyeri pada pasien paliatif (kanker, penyakit kronik progresif, gagal organ, penyakit neurodegeneratif) bersifat kompleks karena melibatkan faktor:

- Fisik: kerusakan jaringan, inflamasi, infiltrasi tumor
- Psikologis: kecemasan, depresi
- Sosial: dukungan keluarga, beban ekonomi
- Spiritual: kehilangan makna, ketakutan akan kematian

Oleh karena itu, nyeri paliatif = pengalaman multidimensional, bukan sekadar sensasi fisik.

B. Fisiologi Nyeri

Fisiologi nyeri merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem saraf perifer, sistem saraf pusat, serta modulasi neurokimia. Secara umum, proses fisiologi nyeri terdiri dari empat tahap utama: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Masing-masing tahap menentukan bagaimana seseorang merasakan, memproses, dan merespons nyeri.

1. Transduksi (Transduction)

Transduksi adalah proses ketika rangsangan berbahaya (mekanik, termal, kimia) dikonversi menjadi sinyal listrik oleh nosiseptor.

Proses

- a. Rangsangan merusak jaringan → pelepasan mediator inflamasi (prostaglandin, bradikinin, serotonin, histamin, substansi P, ion H^+).
- b. Mediator tersebut menurunkan ambang aktivasi nosiseptor → menyebabkan sensitisasi perifer.
- c. Reseptor TRPV1, ASIC, dan P2X memainkan peran penting dalam deteksi stimulus.

2. Transmisi (Transmission)

Transmisi adalah penghantaran impuls nyeri dari nosiseptor menuju sistem saraf pusat. Jalur transmisi

- a. Nosiseptor → Dorsal Root Ganglion (DRG)
- b. Sumsum tulang belakang (horn dorsalis)
 - Sinaps di lamina I, II, dan V (area substantia gelatinosa).
- c. Traktus spinothalamikus → Talamus → Korteks serebri

Serabut yang terlibat

Serabut Saraf	Karakteristik	Jenis Nyeri
A-delta	cepat, bermielin	nyeri tajam, terlokalisasi
C	lambat, tidak bermielin	nyeri tumpul, terbakar, viseral

3. Modulasi (Modulation)

Modulasi adalah proses penguatan atau penghambatan sinyal nyeri sepanjang jalur saraf. Jalur modulasi :

- a. Melibatkan sistem analgesik endogen:

- Enkefalin
- Endorfin
- Dynorphin
- Serotonin (5-HT)
- Noradrenalin

- b. Sistem modulasi terutama bekerja di:

- Sumsum tulang belakang
- Periaqueductal gray (PAG)
- Rostral ventromedial medulla (RVM)

- c. Central sensitization

Fenomena ketika neuron pusat menjadi hiperresponsif sehingga nyeri menjadi kronis. Ditandai dengan:

- Allodynia (nyeri akibat rangsangan non-nyeri)
- Hyperalgesia (nyeri berlebihan)

4. Persepsi (Perception)

Persepsi nyeri adalah proses ketika sinyal dari talamus diinterpretasi oleh otak menjadi pengalaman subjektif "rasa sakit".

Area otak yang berperan

- Korteks somatosensorik → Lokasi & intensitas
- Sistem limbik → Komponen emosional
- Prefrontal cortex → Kognisi dan makna nyeri

Faktor yang mempengaruhi persepsi

- Emosi (cemas, takut → nyeri meningkat)
- Pengalaman masa lalu
- Status spiritual dan sosial
- Dukungan keluarga

C. Fatofisiologi Nyeri

Fatofisiologi nyeri menggambarkan perubahan patologis yang terjadi pada sistem saraf akibat cedera jaringan, inflamasi, atau kerusakan saraf, sehingga menimbulkan pengalaman nyeri yang bersifat akut maupun kronis. Perubahan ini mencakup proses perifer, spinal, dan sentral, yang menyebabkan sistem nyeri menjadi hiperaktif atau gagal terkontrol.

1. Cedera Jaringan → Aktivasi Mediator Inflamasi

Saat jaringan mengalami cedera (trauma, infeksi, tumor, prosedur medis), tubuh melepaskan mediator pro-inflamasi:

- Prostaglandin (PGE2)
- Bradykinin
- Histamin
- Serotonin (5-HT)
- Substance P
- Ion H^+ / ATP

Mediator ini menyebabkan sensitisasi perifer, yaitu peningkatan respons nosiseptor terhadap rangsangan.

Efek klinis:

- Nyeri lebih mudah muncul
- Rangsangan ringan terasa nyeri (hiperalgesia)

2. Aktivasi Nosiseptor (Nociceptor Sensitization)

Terjadi pada reseptor nyeri TRPV1, P2X, ASIC yang menjadi lebih peka terhadap rangsangan termal, kimia, dan mekanik.

Dampaknya:

- Ambang nyeri menurun
- Nyeri berdenyut / panas pada inflamasi

3. Transmisi Nyeri Menuju Sumsum Tulang Belakang

Nyeri dihantarkan melalui dua jenis serabut saraf:

Serabut	Kecepatan	Jenis Nyeri
A-delta	cepat	tajam, terlokalisasi
C	lambat	tumpul, panas, kronis

Impuls masuk ke:

- Lamina I, II (Substantia Gelatinosa)
- Lamina V pada medula spinalis

Terjadi sinaps, pelepasan neurotransmitter:

- Glutamat (cepat)
- Substance P (lama)

4. Perubahan di Sumsum Tulang Belakang (Spinal Sensitization)

Jika rangsangan berulang → neuron spinal mengalami perubahan patologis:

“Wind-up Phenomenon” Peningkatan eksitabilitas karena stimulasi terus-menerus → nyeri makin berat.

Efek:

- Neuron dorsal horn jadi hiperresponsif
- Ambang tembak menurun → nyeri spontan

5. Sensitisasi Sentral (Central Sensitization)

Tahap ini merupakan inti patofisiologi nyeri kronis.

Terjadi karena:

- Aktivasi reseptor NMDA
- Peningkatan glutamat
- Penurunan inhibisi GABA & glycine
- Perubahan genetik di neuron

Akibatnya:

- Nyeri menetap meski cedera telah sembuh
- Allodynia (sentuhan ringan terasa nyeri)
- Hyperalgesia (nyeri berlebih)

6. Gangguan Jalur Penurun Nyeri (Descending Inhibition Failure)

Secara normal, tubuh memiliki sistem analgesik endogen:

- Endorfin
- Enkefalin
- Serotonin
- Noradrenalin

Namun pada kondisi patologis, sistem ini melemah.

Akibatnya:

- Nyeri sulit dihambat
- Nyeri akibat stres emosional meningkat

7. Perubahan Kortikal & Limbik (Pain Matrix Dysfunction)

Pada nyeri kronis, terjadi perubahan struktur dan fungsi otak:

- Aktivitas meningkat di *amygdala* (emosi)
- Aktivitas menurun di *prefrontal cortex* (pengendalian)

- Reorganisasi daerah somatosensorik

Nyeri menjadi pengalaman biopsikososial, bukan hanya sensasi fisik.

8. Kaitan dengan Nyeri di Paliatif

Pada pasien penyakit terminal/kronis (kanker, gagal organ):

Terjadi kombinasi:

- Nociceptive pain (tumor menekan jaringan)
- Neuropathic pain (kerusakan saraf akibat metastasis/kemoterapi)
- Nociplastic pain (disfungsi modulasi sentral)



(Barrett KE, Barman SM, 2020 ; Kuner R, Flor H, 2020; McCaffery M, Pasero C. 2021: Silberstein SD. 2022)

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang pasien dengan penyakit kronis mengatakan mengalami nyeri berat, meskipun pemeriksaan tidak menunjukkan kerusakan jaringan yang jelas. Pasien juga tampak cemas dan merasa tidak dipahami oleh keluarganya. Konsep nyeri yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut adalah

- A. nyeri hanya dapat terjadi apabila ditemukan kerusakan jaringan
- B. nyeri merupakan respons fisiologis yang sama pada setiap individu
- C. nyeri merupakan pengalaman subjektif dan multidimensional
- D. nyeri hanya dipengaruhi oleh rangsangan biologis
- E. nyeri tidak berkaitan dengan kondisi psikologis pasien

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Subjektif dan multidimensional.

Pembahasan:

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan serta bersifat subjektif. Pengalaman nyeri dapat terjadi akibat kerusakan jaringan aktual maupun potensial, bahkan dapat dirasakan tanpa ditemukan bukti kerusakan jaringan yang jelas.

Dalam keperawatan paliatif, nyeri dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, laporan pasien mengenai nyerinya harus diterima sebagai data penting dan tidak boleh diabaikan hanya karena tidak terdapat temuan fisik yang jelas.

Soal 2

Seorang pasien mengalami cedera jaringan setelah menjalani tindakan medis. Cedera tersebut memicu pelepasan prostaglandin, bradikinin, histamin, serotonin, dan substansi P yang menurunkan ambang aktivasi nosiseptor. Tahap fisiologi nyeri yang terjadi adalah

- A. persepsi
- B. modulasi
- C. transmisi
- D. transduksi
- E. sensitisasi sentral

Kunci Jawaban: D

Kata Kunci: Konversi rangsangan menjadi impuls listrik.

Pembahasan:

Transduksi merupakan proses ketika rangsangan mekanik, termal, atau kimia akibat

kerusakan jaringan diubah menjadi sinyal listrik oleh nosiseptor. Pada tahap ini, jaringan yang cedera melepaskan berbagai mediator inflamasi, seperti prostaglandin, bradikinin, histamin, serotonin, substansi P, dan ion hidrogen.

Mediator tersebut menurunkan ambang aktivasi nosiseptor sehingga reseptor nyeri menjadi lebih peka. Kondisi ini disebut sensitisasi perifer dan menyebabkan rangsangan yang sebelumnya ringan dapat menimbulkan nyeri yang lebih kuat.

Soal 3

Seorang pasien mengeluhkan nyeri tajam yang muncul segera setelah kulit tertusuk jarum. Beberapa saat kemudian, nyeri berubah menjadi tumpul, panas, dan berlangsung lebih lama. Serabut saraf yang menghantarkan kedua jenis nyeri tersebut secara berurutan adalah

- A. serabut C kemudian A-delta
- B. serabut A-delta kemudian C
- C. serabut motorik kemudian sensorik
- D. serabut parasimpatis kemudian simpatis
- E. serabut preganglionik kemudian postganglionik

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: A-delta cepat dan C lambat.

Pembahasan:

Serabut A-delta merupakan serabut bermielin yang menghantarkan impuls dengan cepat. Aktivasi serabut ini menghasilkan nyeri yang tajam, segera terasa, dan dapat dilokalisasi dengan cukup jelas.

Serabut C tidak bermielin dan menghantarkan impuls lebih lambat. Nyeri yang ditimbulkan umumnya terasa tumpul, panas, terbakar, menyebar, atau berlangsung lebih lama. Kedua serabut tersebut membawa impuls menuju medula spinalis sebelum diteruskan melalui traktus spinotalamikus menuju talamus dan korteks serebri.

Soal 4

Seorang pasien dengan nyeri kronis mengatakan bahwa sentuhan lembut pada kulit terasa menyakitkan. Pasien juga merasakan nyeri yang sangat berat ketika mendapat rangsangan yang biasanya hanya menimbulkan nyeri ringan. Istilah yang tepat untuk kedua kondisi tersebut adalah

- A. anestesia dan parestesia
- B. analgesia dan hiperalgesia
- C. allodynia dan hiperalgesia

- D. hipestesia dan neuralgia
- E. disestesia dan nosisepsi

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Sensitisasi sentral.

Pembahasan:

Allodynia adalah keadaan ketika rangsangan yang seharusnya tidak menimbulkan nyeri, seperti sentuhan ringan, justru dipersepsikan sebagai nyeri. Sementara itu, hyperalgesia merupakan respons nyeri yang berlebihan terhadap rangsangan yang memang bersifat nyeri.

Kedua kondisi tersebut dapat terjadi akibat sensitisasi sentral. Pada keadaan ini, neuron dalam sistem saraf pusat menjadi hiperresponsif akibat stimulasi berulang, peningkatan glutamat, aktivasi reseptor NMDA, serta menurunnya inhibisi oleh GABA dan glisin.

Soal 5

Seorang pasien kanker stadium lanjut mengalami nyeri akibat massa tumor yang menekan jaringan. Pasien juga merasakan nyeri terbakar setelah menjalani kemoterapi, mengalami kecemasan, merasa menjadi beban keluarga, dan kehilangan makna hidup. Pendekatan manajemen nyeri yang paling tepat adalah

- A. memberikan analgesik tanpa melakukan pengkajian lanjutan
- B. hanya menangani kerusakan saraf akibat kemoterapi
- C. berfokus pada pengangkatan massa tumor sebagai satu-satunya intervensi
- D. melakukan penanganan holistik terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual
- E. menunda intervensi sampai penyebab fisik nyeri dapat ditentukan secara pasti

Kunci Jawaban: D

Kata Kunci: Nyeri multidimensional pada pasien paliatif.

Pembahasan:

Nyeri pada pasien paliatif dapat terdiri atas kombinasi nyeri nosiseptif, neuropatik, dan nosioplastik. Penekanan jaringan oleh tumor dapat menimbulkan nyeri nosiseptif, sedangkan kerusakan saraf akibat metastasis atau kemoterapi dapat menyebabkan nyeri neuropatik.

Pengalaman nyeri pasien juga dipengaruhi oleh kecemasan, perasaan menjadi beban, dukungan keluarga, dan kehilangan makna hidup. Oleh karena itu, penanganan perlu mengintegrasikan terapi farmakologis dengan intervensi nonfarmakologis, dukungan emosional, sosial, keluarga, dan spiritual untuk meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup pasien.

Glosarium

1. Analgesik : Obat penghilang nyeri yang bekerja pada sistem saraf pusat atau perifer.
2. Adjuvant Analgesics : Obat tambahan yang bukan analgesik utama tetapi membantu mengurangi nyeri, seperti antidepresan atau antikonvulsan.
3. Akupunktur : Teknik memasukkan jarum halus pada titik tertentu tubuh untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan relaksasi.
4. Aromaterapi : Penggunaan minyak esensial (essential oils) untuk memberikan efek relaksasi dan mengurangi nyeri atau kecemasan.
5. Deep Breathing (Pernapasan Dalam) : Teknik relaksasi dengan menarik napas perlahan dan dalam untuk mengurangi ketegangan dan nyeri.
6. Guided Imagery : Teknik psikologis di mana pasien membayangkan situasi yang menenangkan untuk mengurangi persepsi nyeri.
7. Hipnoterapi : Pendekatan psikologis yang menggunakan hipnosis untuk mengubah persepsi nyeri dan meningkatkan relaksasi.
8. Intervensi Farmakologi : Pendekatan pengelolaan nyeri menggunakan obat-obatan seperti opioid, NSAID, atau adjuvan.
9. Intervensi Non-Farmakologi : Metode mengurangi nyeri tanpa obat, seperti pijatan ringan, terapi musik, meditasi, atau kompres.
10. Kualitas Nyeri : Deskripsi karakter sensasi nyeri, misal: tajam, menusuk, terbakar, mendenyut.
11. Manajemen Nyeri : Upaya terencana untuk menurunkan intensitas nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien.
12. Meditasi : Latihan mental untuk meningkatkan fokus dan ketenangan yang dapat mengurangi persepsi nyeri.
13. Mindfulness : Teknik perhatian penuh pada momen saat ini untuk mengurangi stres, kecemasan, dan nyeri.
14. Mobilisasi : Gerakan tubuh atau anggota tubuh untuk mengurangi kekakuan dan membantu mengurangi nyeri.
15. Nyeri Akut : Nyeri yang timbul secara tiba-tiba dan biasanya berlangsung singkat.
16. Nyeri Kronik : Nyeri menetap lebih dari 3 bulan, sering terjadi pada pasien kanker atau penyakit terminal.

17. Nyeri Neuropatik : Nyeri akibat kerusakan saraf dengan sensasi seperti terbakar, kesetrum, atau kesemutan.
18. Nyeri Nociceptive : Nyeri akibat kerusakan jaringan, dapat berupa nyeri somatik atau visceral.
19. Opioid : Kelompok obat penghilang nyeri kuat seperti morfin, fentanyl, atau oksikodon, digunakan untuk nyeri sedang–berat.
20. Pain Assessment (Pengkajian Nyeri) : Proses mengidentifikasi intensitas, lokasi, kualitas, pola, pemicu, dan dampak nyeri.
21. Pain Goal : Target nyeri yang disepakati antara pasien dan perawat/dokter sebagai tingkat nyeri yang dapat ditoleransi.
22. Paliatif : Pendekatan perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit serius atau terminal.
23. Pijatan Ringan (Gentle Massage) : Teknik pijat lembut untuk memberikan relaksasi dan menurunkan ketegangan otot.
24. Positioning : Mengatur posisi tubuh untuk mengurangi tekanan dan mengurangi nyeri.
25. Relaksasi : Teknik untuk menurunkan ketegangan otot dan kecemasan, seperti pernapasan dalam atau terapi sentuhan.
26. Musik Terapi (Music Therapy) : Penggunaan musik secara terstruktur untuk menurunkan stres, kecemasan, dan nyeri.
27. Skala Nyeri (Pain Scale) : Instrumen untuk mengukur intensitas nyeri, seperti NRS, VAS, atau Wong-Baker.
28. WHO Pain Ladder : Pedoman bertingkat dari WHO untuk penatalaksanaan nyeri mulai dari non-opioid, opioid lemah, hingga opioid kuat.
29. Therapeutic Touch (Terapi Sentuhan) : Pendekatan dengan sentuhan lembut untuk memberikan ketenangan dan mengurangi ketidaknyamanan.
30. Yoga Ringan : Gerakan lembut dan terstruktur yang dapat membantu merelaksasi tubuh dan menurunkan ketegangan.

Referensi

- Barrett KE, Barman SM, Brooks HL, Yuan JX-J. *Ganong's Review of Medical Physiology*. 26th ed. McGraw-Hill; 2020.
- Kuner R, Flor H. Structural plasticity and reorganisation in chronic pain. *Nat Rev Neurosci*. 2020;21(12):668–76.
- McCaffery M, Pasero C. *Pain: Clinical Manual*. Mosby; 2021.
- Silberstein SD. Physiology and pathophysiology of pain. *Neurol Clin*. 2022;40(1):1–15
- International Association for the Study of Pain (IASP). (2020). *IASP revised definition of pain*. <https://www.iasp-pain.org>
- Lee, J. Y., Lee, Y., & Kim, J. H. (2021). Impact of unrelieved pain on patient outcomes in clinical settings: A systematic review. *Pain Management Nursing*, 22(4), 421–430. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.02.003>
- Panchal, S. J., Damaraju, S., & Nelson, J. (2022). Non-pharmacological management of pain: An integrative review. *Journal of Integrative Pain Management*, 11(2), 95–104. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2021.02.003>
- World Health Organization. (2021). *WHO guideline on the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents*. WHO.
- International Association for the Study of Pain (IASP). *IASP revised definition of pain*. (2020). https://www.nature.com/articles/s41746-023-00810-1?utm_source=chatgpt.com
- "Overview of Pain" – MSD Manual (2025). https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/pain/overview-of-pain?utm_source=chatgpt.com
- Neuropathic Pain: Mechanisms and Treatment (2024). https://www.mdpi.com/2227-9059/12/1/204?utm_source=chatgpt.com
- Nociplastic Pain and Central Sensitization (2024). https://en.wikipedia.org/wiki/Nociplastic_pain?utm_source=chatgpt.com
- World Health Organization. *Integrating Palliative Care and Symptom Relief into Primary Health Care*. WHO; 2022.
- Ferrell BR, Paice JA. *Oxford Textbook of Palliative Nursing*. 5th ed. Oxford University Press; 2023.
- Paice JA. *Management of Cancer Pain*. Journal of Clinical Oncology. 2022.
- Knaul FM, Farmer P. *Alleviating the Access Abyss in Palliative Care and Pain Relief*. Lancet Commission; 2020.

- Cebolla A, Demarzo M. Mindfulness and pain management. *Current Opinion in Supportive and Palliative Care*. 2021.
- Lee JH. Music therapy for pain and anxiety in palliative patients. *Palliative Medicine Reports*. 2021.
- Dones I, et al. Non-pharmacological therapies for cancer pain. *Journal of Pain Research*. 2022.
- Boland JW. Complementary therapies in palliative care. *BMJ Supportive & Palliative Care*. 2023.
- Mercadante S. Massage and touch therapy in cancer pain. *Supportive Care in Cancer*. 2020.
- Ngamkham S. Mind-body interventions for pain. *Seminars in Oncology Nursing*. 2020.

BAB 4

MANAJEMEN SESAK NAPAS DAN GEJALA RESPIRASI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dan filosofi keperawatan paliatif, pendekatan holistik, serta prinsip kualitas hidup dan patient-centered care.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu melakukan penilaian paliatif komprehensif (fisik, psikologis, sosial, spiritual) dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas secara sistematis.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu merancang dan melaksanakan manajemen gejala utama (nyeri, sesak, GI, kelelahan, distres psikologis) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) serta kolaborasi interprofesional dan advokasi pasien–keluarga.	CPMK-3; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, sensitivitas budaya, dan dukungan spiritual dalam asuhan paliatif termasuk akhir hayat.	CPMK-6; CPMK-1; CPMK-7
CPL-6	Mampu mengevaluasi luaran paliatif, melakukan dokumentasi, discharge/home care planning, serta dukungan caregiver dan bereavement berbasis kebutuhan.	CPMK-7; CPMK-6; CPMK-5

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan paliatif, filosofi perawatan, prinsip kualitas hidup, dan ruang lingkup layanan paliatif.
CPMK-2	Melakukan identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif (fisik–psikologis–sosial–spiritual) serta menetapkan prioritas kebutuhan.
CPMK-3	Menerapkan komunikasi paliatif (kabar sulit, perencanaan perawatan/ACP) dan pengambilan keputusan bersama pasien–keluarga secara etis.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan manajemen nyeri dan gejala utama paliatif berbasis bukti, termasuk monitoring efektivitas dan efek samping.
CPMK-5	Melaksanakan asuhan akhir hayat dan dukungan keluarga/caregiver (termasuk bereavement care) dengan fokus kenyamanan dan keselamatan.
CPMK-6	Menginisiasi kolaborasi interprofesional, dukungan spiritual-budaya, serta advokasi dan koordinasi layanan (home care/rujukan).

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Mengevaluasi luaran paliatif, menyusun dokumentasi dan rencana tindak lanjut, serta refleksi perbaikan mutu layanan berbasis indikator.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Manajemen Sesak Napas dan Gejala Respirasi	4.1 Menilai derajat sesak dan pemicu untuk menentukan prioritas intervensi kenyamanan.	4.2 Melaksanakan intervensi farmakologis/nonfarmakologis dan evaluasi respons terukur.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-6

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE penilaian paliatif komprehensif + checklist	Kelengkapan penilaian (fisik-psiko-sosio-spiritual) dan ketepatan penetapan prioritas kebutuhan (checklist).	15	Checklist OSCE; lembar penilaian
CPMK-4	Skill station manajemen gejala (nyeri/sesak/GI) + checklist	Ketepatan penilaian gejala, pemilihan intervensi, dan evaluasi respons terukur (persentase langkah benar).	20	Checklist keterampilan; catatan respons
CPMK-6	Proyek rencana kolaborasi spiritual-budaya & koordinasi layanan	Kualitas pemetaan kebutuhan spiritual-budaya, rencana kolaborasi/rujukan, dan indikator tindak lanjut (skor rubrik).	10	Rencana kolaborasi; peta rujukan

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep paliatif (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan prinsip paliatif pada skenario	Keliru/berisiko	Cukup tepat; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat & komprehensif

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan penilaian komprehensif (checklist)	≤60% komponen terpenuhi; data penting hilang	61–75% terpenuhi; masih ada kekurangan bermakna	76–90% terpenuhi; kekurangan minor	>90% terpenuhi; sangat sistematis
2.2 Ketepatan penetapan prioritas kebutuhan	Prioritas tidak sesuai beban gejala	Cukup sesuai; masih ada ketidaktepatan	Sesuai; prioritas jelas	Sangat sesuai; prioritas sangat logis & terdokumentasi

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kualitas komunikasi kabar sulit/ACP	Tidak terstruktur; kurang empatik	Terstruktur sebagian; empati terbatas	Terstruktur; empatik; jelas	Sangat terstruktur; empati tinggi; responsif terhadap nilai pasien
3.2 Kelengkapan tujuan perawatan/ACP terdokumentasi	Tidak lengkap; tidak dapat ditindaklanjuti	Cukup lengkap; masih umum	Lengkap; tujuan spesifik	Sangat lengkap; tujuan sangat spesifik & terukur + tindak lanjut jelas

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan penilaian gejala & target (nyeri/sesak/GI)	Penilaian tidak tepat; tanpa target	Penilaian cukup; target kurang jelas	Penilaian tepat; target jelas	Penilaian sangat tepat; target spesifik dan realistis
4.2 Ketepatan intervensi & evaluasi respons	Intervensi tidak sesuai; evaluasi tidak ada	Intervensi cukup; evaluasi terbatas	Intervensi sesuai; evaluasi jelas	Intervensi sangat sesuai; evaluasi komprehensif & terdokumentasi

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan comfort care & keselamatan tindakan	Tidak sesuai tujuan perawatan; risiko tinggi	Cukup sesuai; ada kekurangan bermakna	Sesuai; aman; konsisten	Sangat sesuai; sangat aman; antisipatif komplikasi
5.2 Kualitas dukungan keluarga & bereavement readiness	Tidak responsif; tanpa rencana	Respons ada; rencana umum	Respons baik; rencana tindak lanjut jelas	Dukungan sangat baik; rencana bereavement sangat jelas & terukur

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pemetaan kebutuhan spiritual-budaya & preferensi	Tidak teridentifikasi	Teridentifikasi sebagian	Teridentifikasi jelas	Sangat jelas; mempertimbangkan nilai/ritual kunci
6.2 Kualitas rencana kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak ada rencana; peran tidak jelas	Ada rencana; koordinasi kurang runtut	Koordinasi jelas; indikator tindak lanjut ada	Koordinasi sangat efektif; indikator komprehensif & keberlanjutan kuat

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran paliatif berbasis indikator	Tidak menggunakan indikator	Indikator terbatas; analisis minim	Indikator memadai; analisis jelas	Indikator komprehensif; analisis kritis & akurat
7.2 Kualitas rencana tindak lanjut/home care	Tidak spesifik; tidak terukur	Cukup spesifik; sebagian terukur	Spesifik; terukur; realistis	Sangat spesifik, terukur, realistis; koordinasi layanan jelas

Pendahuluan

Sesak napas, yang sering disebut sebagai dispnea, merupakan salah satu gejala paling mengganggu dan umum dialami oleh pasien dengan penyakit lanjut (*life-threatening illness*) (Kavalieratos et al., 2017). Gejala ini bersifat subjektif dan ditandai dengan sensasi tidak nyaman dalam bernapas, yang dapat terjadi bahkan tanpa adanya kelainan fisiologis yang signifikan (Rogers et al., 2023; Suha et al., 2025). Dalam konteks perawatan paliatif, sesak napas sering dikaitkan dengan kondisi seperti kanker stadium lanjut, penyakit paru obstruktif kronis, gagal jantung, dan gangguan neurologis progresif (Rogers et al., 2023). Selain dimensi fisiknya, sesak napas juga berdampak besar pada kesejahteraan psikologis, sering memicu kecemasan, ketakutan, serta perasaan kehilangan kendali, sehingga menurunkan kualitas hidup pasien dan keluarganya (Booth & Johnson, 2019).

Sindrom respirasi dalam perawatan paliatif bersifat multifaktorial dan sering kali kompleks, melibatkan interaksi antara faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Mekanisme yang mendasari dapat meliputi gangguan pertukaran gas, peningkatan kerja pernapasan, kelemahan otot pernapasan, obstruksi jalan napas, atau perubahan persepsi sentral terhadap sesak napas (Suha et al., 2025). Penting

untuk dipahami bahwa tingkat keparahan sesak napas tidak selalu sejalan dengan temuan klinis objektif, sehingga menegaskan perlunya pendekatan penilaian yang holistik dan berpusat pada pasien. Memahami sesak napas sebagai “total symptom” sejalan dengan filosofi perawatan paliatif yang menekankan pengurangan penderitaan dalam segala bentuknya (Booth & Johnson, 2019).

Penatalaksanaan sesak napas yang efektif memerlukan strategi yang komprehensif dan individual. Intervensi farmakologis seperti opioid dosis rendah, ansiolitik, dan bronkodilator dapat digunakan untuk mengurangi intensitas gejala (Feliciano et al., 2021). Namun, pendekatan non-farmakologis juga sama pentingnya, termasuk teknik pernapasan, pengaturan posisi, penggunaan kipas tangan, terapi relaksasi, serta dukungan psikososial (Bausewein et al., 2008; Booth et al., 2011; Pyszora & Lewko, 2022). Kolaborasi interdisipliner antar tenaga kesehatan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai faktor penyebab sesak napas dan memastikan bahwa perawatan yang diberikan berbasis bukti serta sesuai dengan preferensi dan tujuan pasien (Bendowska & Baum, 2023).

Dalam perawatan paliatif, penanganan sesak napas tidak hanya berfokus pada pengendalian gejala, tetapi juga mencakup komunikasi, edukasi, dan perencanaan perawatan lanjutan. Diskusi terbuka mengenai prognosis, harapan, dan strategi koping dapat memberdayakan pasien dan keluarga dalam menghadapi tantangan akibat gangguan pernapasan. Dukungan bagi *caregiver*, perhatian terhadap aspek eksistensial, serta kesinambungan perawatan merupakan komponen penting dalam praktik paliatif yang berkualitas. Pada akhirnya, pendekatan yang penuh empati dan sensitif terhadap budaya dapat membantu pasien mencapai kenyamanan, martabat, dan makna hidup, meskipun menghadapi sesak napas yang persisten.

Tujuan Instruksional:

- Memahami konsep dasar sesak napas (dispnea) sebagai gejala subjektif pada pasien dengan penyakit lanjut.
- Mengidentifikasi berbagai penyebab dan mekanisme yang mendasari sindrom respirasi dalam konteks perawatan paliatif.
- Menjelaskan dampak fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari sesak napas terhadap pasien dan keluarganya.
- Melakukan pengkajian sesak napas secara holistik dan berpusat pada pasien.
- Mendeskripsikan prinsip-prinsip penatalaksanaan sesak napas, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis.
- Mengaplikasikan pendekatan interdisipliner dalam mengelola pasien dengan gangguan respirasi di layanan paliatif.
- Mengembangkan keterampilan komunikasi dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada pasien serta keluarga terkait sesak napas.

- Memahami pentingnya pendekatan yang empatik, berbudaya, dan berorientasi pada kualitas hidup dalam penanganan sesak napas di akhir hayat.

Uraian Materi

Bab ini menguraikan konsep sesak napas (dispnea) sebagai gejala subjektif yang umum pada pasien dengan penyakit lanjut, termasuk mekanisme dan penyebab multifaktorial yang mendasari sindrom respirasi dalam konteks perawatan paliatif. Pembahasan mencakup dampak menyeluruh sesak napas terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien serta keluarganya, sekaligus menekankan pentingnya pengkajian yang holistik dan berpusat pada pasien. Selain itu, dijelaskan prinsip-prinsip penatalaksanaan yang komprehensif, baik melalui intervensi farmakologis maupun non-farmakologis, dengan dukungan pendekatan interdisipliner. Bab ini juga menyoroti pentingnya komunikasi terapeutik, edukasi, serta dukungan emosional bagi pasien dan keluarga, serta penerapan pendekatan yang empatik, sensitif budaya, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dalam menghadapi sesak napas pada fase akhir kehidupan.

A. Definisi Sesak Napas & Gejala Respirasi

Sesak napas didefinisikan secara luas sebagai pengalaman subjektif berupa ketidaknyamanan dalam bernapas, yang mencakup berbagai sensasi seperti *“air hunger”*, peningkatan usaha bernapas, atau perasaan tercekik (Kamal et al., 2011). Definisi ini digunakan secara konsisten oleh berbagai organisasi internasional seperti *American Thoracic Society* dan literatur global, yang menekankan bahwa dispnea tidak hanya merupakan fenomena fisiologis, tetapi juga pengalaman perseptual yang hanya dapat dinilai secara akurat oleh pasien sendiri (Kamal et al., 2011). Di berbagai negara, termasuk dalam konteks Amerika Utara, Eropa, hingga layanan *hospice global*, dispnea dilaporkan sebagai salah satu gejala paling umum pada penyakit lanjut, terjadi pada lebih dari 50–70% pasien kanker dan hingga 90% pasien pada fase akhir kehidupan (Rogers et al., 2023). Keunikan sesak napas dibandingkan gejala lain, khususnya dalam perawatan paliatif, terletak pada sifatnya yang multidimensional dan eksistensial: selain melibatkan gangguan fisiologis, gejala ini juga memicu respons emosional yang kuat seperti kecemasan dan ketakutan akan kematian, bahkan sering dianggap sebagai *“ancaman asfiksia”* yang sangat *distressing* atau cukup membuat stress (Campbell, 2012). Oleh karena itu, dalam praktik paliatif modern, berkembang konsep *“total dyspnea”* yang mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, menjadikannya salah satu gejala paling kompleks dan menantang untuk dinilai serta ditangani dibandingkan gejala lainnya (Kamal et al., 2011).

B. Etiologi

Etiologi dispnea dan gejala respiratori pada pasien dengan penyakit lanjut bersifat multifaktorial dan kompleks, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur klinis dan paliatif (Rogers et al., 2023). Penyebabnya tidak hanya terbatas pada gangguan organ tertentu, tetapi juga melibatkan interaksi antara faktor fisiologis dan non-fisiologis yang saling memengaruhi. Dalam praktik perawatan paliatif, konsep *total dyspnea* menekankan bahwa sesak napas merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang dapat berubah seiring perjalanan penyakit, sehingga memerlukan pengkajian yang komprehensif dan berkelanjutan (Kamal et al., 2011).

Secara umum, etiologi dispnea dan gejala respiratori dapat meliputi (Kamal et al., 2011; Rogers et al., 2023; Shin et al., 2023):

1. Faktor pulmoner: seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), pneumonia, efusi pleura, edema paru, dan metastasis paru;
2. Faktor kardiovaskular: termasuk gagal jantung, penyakit jantung iskemik, dan aritmia;
3. Faktor hematologis: seperti anemia yang menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen;
4. Faktor neuromuskular: misalnya kelemahan otot pernapasan, penyakit neuron motorik, atau kelelahan berat;
5. Faktor metabolik dan sistemik: seperti asidosis metabolik, infeksi sistemik, atau cachexia;
6. Faktor psikologis: termasuk kecemasan, depresi, dan ketakutan yang dapat memperburuk persepsi sesak napas;
7. Faktor lingkungan dan sosial: seperti kualitas udara, ventilasi ruangan, serta dukungan sosial yang terbatas.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa pada pasien paliatif, penyebab sesak napas jarang bersifat tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap etiologi yang beragam ini menjadi dasar penting dalam menentukan strategi penatalaksanaan yang tepat, individual, dan berpusat pada pasien.

C. Faktor Resiko

Dispnea dan gejala respirasi lain merupakan keluhan yang sangat umum pada pasien paliatif, terutama karena kondisi penyakit yang progresif dan kompleks. Faktor risikonya bersifat multifaktorial, melibatkan aspek penyakit primer,

komorbiditas, hingga faktor psikososial (Campbell, 2012; Kamal et al., 2011; Rogers et al., 2023; Shin et al., 2023; Suha et al., 2025).

1. Faktor terkait penyakit utama (underlying disease)
 - a. Kanker, terutama kanker paru, metastasis paru, atau efusi pleura
 - b. Penyakit paru kronis seperti *Chronic Obstructive Pulmonary Disease*
 - c. Gagal jantung (*Heart Failure*)
 - d. Penyakit neurodegeneratif seperti *Amyotrophic Lateral Sclerosis*
2. Faktor fisiologis dan patofisiologis
 - a. Hipoksemia (penurunan oksigen darah)
 - b. Hiperkapnia (peningkatan CO₂)
 - c. Anemia
 - d. Asidosis metabolik atau respiratorik
 - e. Kelemahan otot respirasi (misalnya karena *cachexia* atau imobilisasi)
3. Faktor mekanik dan struktural
 - a. Efusi pleura
 - b. Atelektasis
 - c. Obstruksi jalan napas (tumor, sekret, atau edema)
 - d. Asites berat
4. Faktor terkait terapi dan perawatan
 - a. Efek samping pengobatan, seperti kemoterapi atau radioterapi (fibrosis paru) dan obat tertentu yang menekan pusat napas
 - b. Overhidrasi
 - c. Kurangnya mobilisasi
5. Faktor infeksi
 - a. Infeksi saluran napas (misalnya pneumonia)
 - b. Sepsis
6. Faktor psikologis dan emosional
 - a. Ansietas dan panik
 - b. Depresi
 - c. Interaksi antara pikiran dan sensasi fisik
7. Faktor lingkungan dan sosial
 - a. Kualitas udara buruk
 - b. Ventilasi ruangan tidak adekuat
 - c. Dukungan keluarga yang kurang dalam manajemen gejala
8. Faktor terminal (*end-of-life*)
 - a. Penurunan kesadaran
 - b. Penumpukan sekret (death rattle)
 - c. Kelelahan ekstrem (terminal fatigue).

D. Patofisiologi

Dispnea pada pasien paliatif terjadi akibat interaksi kompleks antara gangguan fisiologis, mekanik, dan persepsi sentral yang menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ventilasi dan kemampuan sistem respirasi untuk memenuhinya. Kondisi seperti *Chronic Obstructive Pulmonary Disease*, *Heart Failure*, atau kanker paru menyebabkan gangguan pertukaran gas melalui mekanisme seperti *mismatch* ventilasi-perfusi, *shunting*, dan gangguan difusi, yang berujung pada hipoksemia dan/atau hiperkapnia (Albrecht, 2025; Bruera et al., 2015; Cherny, 2021; Hanks, 2011). Perubahan ini dideteksi oleh kemoreseptor sentral dan perifer yang kemudian meningkatkan drive pernapasan. Namun, pada saat yang sama, gangguan mekanika pernapasan seperti peningkatan resistensi jalan napas, penurunan *compliance* paru, serta kelemahan otot respirasi, misalnya pada kondisi *cachexia* atau penyakit neuromuskular seperti *Amyotrophic Lateral Sclerosis*, membatasi kemampuan tubuh untuk meningkatkan ventilasi secara efektif. Aktivasi mekanoreseptor akibat peregangan paru, obstruksi, atau penumpukan cairan (misalnya efusi pleura atau edema paru) semakin memperkuat sinyal ke pusat pernapasan. Seluruh impuls aferen ini kemudian diproses di sistem saraf pusat, termasuk area korteks dan sistem limbik, yang memediasi persepsi subjektif dispnea, sehingga sensasi sesak tidak hanya ditentukan oleh derajat gangguan fisiologis tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti ansietas dan panik. Pada fase terminal, kondisi diperburuk oleh penurunan kesadaran, akumulasi sekret, dan kelelahan otot napas yang menyebabkan ventilasi menjadi semakin tidak efektif, sehingga memperkuat siklus sesak napas yang progresif dan sulit dikompensasi.

E. Klasifikasi

Klasifikasi dispnea dan gejala respiratori pada pasien paliatif dapat dilihat dari beberapa pendekatan berdasarkan mekanisme, waktu, intensitas, dan manifestasi klinis, karena gejala ini bersifat multidimensional dan subjektif (Albrecht, 2025; Bruera et al., 2015; Cherny, 2021; Hanks, 2011).

1. Klasifikasi berdasarkan mekanisme (patofisiologi)

- a. Dispnea akibat gangguan ventilasi, seperti pada *Chronic Obstructive Pulmonary Disease* (COPD), asma, dan obstruksi jalan napas oleh karena adanya tumor
- b. Dispnea akibat gangguan perfusi atau sirkulasi, seperti pada gagal jantung dan emboli paru
- c. Dispnea akibat gangguan difusi atau pertukaran gas, seperti pada pneumonia, fibrosis, atau metastasis paru

- d. Dispnea akibat gangguan neuromuskular, seperti pada Amyotrophic Lateral Sclerosis
- e. Dispnea psikogenik, seperti pada kasus ansietas, panik, atau distress emosional yang dialami oleh pasien paliatif
- 2. Klasifikasi berdasarkan waktu dan pola
 - a. Akut, seperti pada emboli atau edema paru
 - b. Kronik, seperti pada COPD atau kanker paru
 - c. Episodik atau *breakthrough dyspnea*
 - d. Dispnea saat aktivitas (*exertional dyspnea*)
 - e. Dispnea saat istirahat (*rest dyspnea*)
- 3. Klasifikasi berdasarkan derajat keparahan
 - a. Ringan
 - b. Sedang
 - c. Berat
- 4. Klasifikasi gejala respiratori lainnya
Contoh: batuk, *wheezing*, takipnea, *death rattle*, atau stridor.
- 5. Klasifikasi dalam konteks paliatif
 - a. Reversible dyspnea (dapat ditangani (misalnya infeksi, efusi pleura))
 - b. Irreversible dyspnea (akibat penyakit progresif)
 - c. Total dyspnea (kombinasi faktor fisik, psikologis, sosial, dan spiritual)

F. Manifestasi Klinik

Manifestasi klinik dispnea dan gejala respiratori pada pasien paliatif bersifat multidimensional, mencakup aspek subjektif (apa yang dirasakan pasien) dan objektif (apa yang dapat diamati klinisi), serta sering berkembang seiring progresivitas penyakit (Albrecht, 2025; Bruera et al., 2015; Cherny, 2021; Hanks, 2011).

1. Manifestasi subjektif (gejala yang dirasakan pasien)
 - a. *Air hunger* (lapar udara) atau perasaan tidak cukup mendapatkan udara
 - b. Napas terasa berat (*effortful breathing*) atau peningkatan usaha bernapas
 - c. Rasa tertekan di dada atau *chest tightness*
 - d. Tidak nyaman saat bernapas yang sulit dijelaskan secara spesifik, kadang-kadang pasien menggunakan istilah-istilah seperti "nafas ampeg" atau "sengkil".

Umumnya untuk manifestasi subjektif seperti ini, dokumentasi hasil pengkajian dapat dituliskan apa adanya, sesuai yang disampaikan oleh pasien. Misalnya: Data subjektif: "nafas sengkil".

2. Manifestasi objektif (tanda klinis yang dapat diamati)
 - a. Takipnea (peningkatan frekuensi napas)
 - b. Penggunaan otot bantu napas (*sternokleidomastoideus*, interkostal)
 - c. Retraksi dinding dada (untuk mendapatkan data ini, pastikan mata pemeriksa sejajar dengan thorax pasien, untuk bisa sampai melihat pergerakan dada dan sekaligus membandingkannya antara kiri dan kanan)
 - d. Pernapasan dangkal atau tidak teratur
 - e. Sianosis (pada hipoksemia berat)
 - f. Nasal flaring (pelebaran cuping hidung)
3. Manifestasi perilaku dan fungsional
 - a. Penurunan toleransi aktivitas (mudah lelah)
 - b. Kesulitan berbicara (berbicara terputus-putus)
 - c. Posisi ortopnea (lebih nyaman duduk daripada berbaring)
 - d. Keterbatasan aktivitas sehari-hari (activity daily living atau ADL)
4. Manifestasi psikologis dan emosional
 - a. Ansietas dan panik
 - b. Rasa takut akan kematian (fear of suffocation)
 - c. Agitasi atau gelisah
5. Manifestasi pada fase terminal (end-of-life)
 - a. Pola napas tidak teratur (misalnya *Cheyne-Stokes*)
 - b. Penumpukan sekret (*death rattle*) akibat penurunan refleks menelan dan batuk
 - c. Penurunan kesadaran
 - d. Kelelahan otot napas
6. Manifestasi gejala respiratori lainnya
Contoh: batuk, *wheezing*, takipnea, *death rattle*, atau stridor.

G. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada dispnea dan gejala respiratori pada pasien paliatif bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab yang masih reversibel, menilai derajat gangguan, serta memandu tatalaksana yang proporsional, dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan pasien dan tujuan perawatan (*goal of care*). Pendekatannya biasanya lebih selektif dibandingkan pasien kuratif, karena perlu pertimbangan terkait manfaat dari pemeriksaan tersebut (Albrecht, 2025; Bruera et al., 2015; Cherny, 2021; Hanks, 2011). Apalagi di fase *end-of-life care*, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan manfaat tindakan dibandingkan dengan *futility*-nya (kesia-siaan). Meskipun di dalam budaya Indonesia sangat dikenal istilah "ikhtiar, yaitu upaya yang perlu dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan,

demis pasien, tetapi di fase akhir kehidupan, pemeriksaan mungkin hanya akan menambah penderitaan pasien dan beban finansial keluarga. Tenaga kesehatan perlu memberikan pengertian, informasi, dan edukasi supaya menjadikan kenyamanan pasien adalah prioritas, dibandingkan dengan berbagai tindakan pemeriksaan (Kustanti & Nobe, 2024; Martina, Kustanti, Dewantari, Sutandyo, Putranto, Shatri, Effendy, van der Heide, Rietjens, et al., 2022; Martina, Kustanti, Dewantari, Sutandyo, Putranto, Shatri, Effendy, van der Heide, van der Rijt, et al., 2022; Purqoti; et al., 2025).

Jika diperlukan, jenis pemeriksaan penunjang yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan laboratorium, seperti Analisis gas darah (AGD) atau Pemeriksaan darah rutin
2. Pemeriksaan radiologi, seperti USG toraks
3. Pemeriksaan fungsi respirasi, seperti saturasi oksigen
4. Pemeriksaan kardiovaskular, seperti elektrokardiografi

H. Intervensi dan Implementasi

Intervensi dispnea dan gejala respiratori pada pasien paliatif dapat dikaitkan secara sistematis dengan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), khususnya dalam kerangka diagnosis keperawatan seperti bersihan jalan napas tidak efektif, pola napas tidak efektif, dan gangguan pertukaran gas (Februanti, 2020). Dalam SIKI, intervensi utama yang relevan meliputi manajemen jalan napas, manajemen pernapasan, dan manajemen oksigenasi, yang diimplementasikan melalui tindakan seperti memposisikan pasien *semi-fowler* untuk meningkatkan ekspansi paru, memantau frekuensi dan pola napas, serta mengajarkan teknik pernapasan seperti *pursed-lip breathing*. Selain itu, intervensi monitoring respirasi menekankan pengkajian berkelanjutan terhadap tanda-tanda distress napas, penggunaan otot bantu, dan saturasi oksigen, yang sangat penting karena pada pasien paliatif sering terdapat ketidaksesuaian antara tanda objektif dan keluhan subjektif.

Dalam konteks gejala respiratori lain, SIKI juga mencakup manajemen batuk dan manajemen sekresi jalan napas, yang dapat dilakukan melalui hidrasi adekuat, fisioterapi dada ringan, reposisi pasien, serta kolaborasi pemberian terapi farmakologis seperti bronkodilator atau antitusif sesuai indikasi. Untuk pasien dengan kecemasan yang memperburuk dyspnea, intervensi reduksi ansietas dalam SIKI menjadi penting, misalnya dengan teknik relaksasi, komunikasi terapeutik, dan dukungan emosional. Pada kondisi seperti *Chronic Obstructive Pulmonary Disease*

atau *Heart Failure*, intervensi kolaboratif dalam SIKI memungkinkan pemberian oksigen, diuretik, atau opioid sesuai program medis. Pada fase terminal, SIKI juga mendukung pendekatan perawatan kenyamanan (*comfort care*) dengan fokus pada pengurangan distress, termasuk pengelolaan sekret (misalnya *death rattle*) melalui reposisi dan kolaborasi pemberian antikolinergik. Dengan demikian, SIKI memberikan kerangka praktik yang komprehensif dan terstandar untuk memastikan intervensi keperawatan pada dispnea paliatif tetap berbasis *evidence*, terstruktur, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien.

I. Evaluasi

Evaluasi asuhan keperawatan pada dispnea dan gejala respiratori dalam area paliatif, berdasarkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), berfokus pada pencapaian luaran yang mencerminkan perbaikan kenyamanan, stabilitas respirasi, dan penurunan distress pasien, bukan semata normalisasi parameter fisiologis (Februanti, 2020). Luaran utama yang digunakan umumnya meliputi status pernapasan, bersihan jalan napas, dan tingkat kenyamanan, yang dinilai melalui indikator subjektif dan objektif. Secara subjektif, evaluasi dilakukan dengan menilai penurunan keluhan sesak napas, berkurangnya sensasi *air hunger*, serta meningkatnya kemampuan pasien untuk beraktivitas ringan atau berbicara tanpa terputus. Secara objektif, perawat mengevaluasi frekuensi dan pola napas yang lebih teratur, berkurangnya penggunaan otot bantu napas, penurunan takipnea, serta perbaikan saturasi oksigen (bila diukur), dengan tetap menyadari bahwa pada pasien paliatif, parameter objektif tidak selalu sejalan dengan persepsi pasien.

Selain itu, pada luaran bersihan jalan napas, indikator keberhasilan mencakup berkurangnya sekret, batuk yang lebih efektif, serta tidak adanya bunyi napas tambahan seperti *wheezing* atau ronki yang mengganggu. Pada aspek psikologis, luaran seperti tingkat kecemasan menurun juga menjadi bagian penting, ditandai dengan pasien tampak lebih tenang, tidak gelisah, dan mampu mengontrol napasnya. Dalam konteks paliatif, evaluasi juga harus mempertimbangkan tujuan perawatan yang berorientasi pada kenyamanan (*comfort-oriented goals*), sehingga keberhasilan intervensi dapat diartikan sebagai tercapainya kondisi di mana pasien merasa lebih nyaman, distress berkurang, dan kualitas hidup meningkat, meskipun penyakit dasar seperti *Chronic Obstructive Pulmonary Disease* atau *Heart Failure* tetap progresif. Dengan demikian, evaluasi berbasis SLKI menekankan pendekatan individual, berkelanjutan, dan berpusat pada pengalaman pasien sebagai indikator utama keberhasilan asuhan keperawatan.

J. Edukasi

Edukasi yang diberikan oleh perawat dalam asuhan keperawatan pasien paliatif dengan dispnea dan gejala respiratori lainnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga dalam mengelola gejala secara mandiri, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Edukasi ini sejalan dengan intervensi dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia seperti edukasi kesehatan, manajemen pernapasan, dan reduksi ansietas, serta dievaluasi melalui luaran dalam Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Februanti, 2020). Secara umum, perawat perlu memberikan edukasi mengenai pemahaman dasar tentang dispnea, termasuk bahwa sesak napas merupakan gejala yang umum terjadi pada penyakit lanjut seperti *Chronic Obstructive Pulmonary Disease* atau *Heart Failure*, sehingga pasien dan keluarga tidak panik ketika gejala muncul. Edukasi kemudian difokuskan pada strategi non-farmakologis, seperti mengatur posisi nyaman (misalnya duduk atau *semi-fowler*), menggunakan teknik pernapasan seperti *pursed-lip breathing*, serta memanfaatkan aliran udara (kipas atau ventilasi ruangan) untuk mengurangi sensasi sesak. Selain itu, pasien diajarkan manajemen energi, seperti mengatur aktivitas sehari-hari agar tidak memicu kelelahan dan sesak berlebih.

Perawat juga perlu memberikan edukasi terkait penggunaan terapi farmakologis, termasuk cara penggunaan oksigen (jika diresepkan), inhaler, atau obat lain seperti opioid dosis rendah untuk dispnea, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Edukasi ini mencakup pengenalan efek samping dan kapan harus melaporkan perubahan kondisi. Dalam hal gejala lain, seperti batuk dan produksi sekret, pasien dan keluarga dapat diajarkan teknik batuk efektif, menjaga hidrasi, serta cara reposisi untuk membantu pengeluaran sekret.

Aspek penting lainnya adalah edukasi psikologis dan emosional, di mana perawat membantu pasien dan keluarga memahami hubungan antara kecemasan dan sesak napas, serta mengajarkan teknik relaksasi sederhana, seperti napas dalam atau distraksi. Edukasi juga mencakup tanda bahaya yang perlu diwaspadai, seperti sesak yang memburuk secara tiba-tiba, perubahan kesadaran, atau bunyi napas abnormal (misalnya stridor), sehingga keluarga dapat segera mencari bantuan. Dalam fase terminal, perawat perlu memberikan edukasi tentang kondisi yang mungkin terjadi, seperti penumpukan sekret (*death rattle*), agar keluarga memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses alami dan dapat dikelola untuk kenyamanan pasien.

Dengan demikian, edukasi dalam konteks paliatif tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan persiapan keluarga,

sehingga tercapai perawatan yang komprehensif, berpusat pada pasien, dan meningkatkan kualitas hidup.

K. Dokumentasi

Prinsip-prinsip pendokumentasian proses keperawatan pada pasien paliatif dengan dispnea dan gejala respiratori lainnya menekankan pada akurasi, kontinuitas, dan orientasi pada kenyamanan pasien, serta harus selaras dengan standar nasional seperti Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (Februanti, 2020). Dokumentasi tidak hanya mencatat kondisi klinis, tetapi juga mencerminkan proses berpikir klinis perawat dalam memberikan asuhan yang holistik.

Secara prinsip, dokumentasi harus lengkap dan sistematis mengikuti tahapan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi). Pada tahap pengkajian, perawat perlu mencatat secara detail keluhan subjektif seperti intensitas sesak, sensasi yang dirasakan (misalnya *air hunger* atau napas berat), serta faktor pencetus dan pembeda, disertai data objektif seperti frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu, dan saturasi oksigen. Karena dispnea bersifat subjektif, dokumentasi harus menekankan perspektif pasien sebagai pusat penilaian.

Selanjutnya, diagnosis keperawatan dituliskan secara jelas dan berbasis data, misalnya pola napas tidak efektif atau bersihan jalan napas tidak efektif. Pada bagian intervensi dan implementasi, dokumentasi harus mencerminkan tindakan yang telah dilakukan sesuai standar (misalnya manajemen jalan napas, posisi *semi-fowler*, teknik pernapasan, atau kolaborasi pemberian terapi), termasuk respon pasien terhadap tindakan tersebut. Prinsip penting lainnya adalah *real-time documentation*, yaitu pencatatan dilakukan segera setelah tindakan untuk menjaga akurasi. Pendokumentasian proses keperawatan adalah yang dilakukan oleh perawat dan melaksanakan yang sudah direncanakan, tentu saja dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi (*"do what you write and write what you do"*).

Pada tahap evaluasi, perawat harus mendokumentasikan perubahan kondisi pasien berdasarkan indikator luaran dalam SLKI, seperti penurunan tingkat sesak, perbaikan pola napas, atau peningkatan kenyamanan. Dalam konteks paliatif, keberhasilan tidak selalu berarti perbaikan fisiologis, tetapi lebih pada penurunan distress dan peningkatan kualitas hidup, sehingga dokumentasi harus mencerminkan tujuan perawatan yang berorientasi pada *comfort care*. Selain itu, dokumentasi harus memenuhi prinsip legal, etis, dan komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, objektif, tidak bias, serta dapat dipahami oleh tim

multidisiplin. Aspek komunikasi dengan pasien dan keluarga, termasuk edukasi, dukungan emosional, dan pengambilan keputusan terkait perawatan, juga perlu dicatat sebagai bagian dari asuhan komprehensif. Dengan demikian, dokumentasi keperawatan pada pasien paliatif dengan dispnea tidak hanya berfungsi sebagai catatan klinis, tetapi juga sebagai alat komunikasi profesional dan bukti akuntabilitas dalam memberikan perawatan yang berpusat pada pasien.

L. Latihan Soal

Soal 1

Seorang pasien dengan kanker stadium lanjut mengatakan, "Saya merasa seperti tidak mendapatkan cukup udara." Hasil pemeriksaan menunjukkan frekuensi napas 22 kali/menit dan saturasi oksigen 95%. Pasien tampak cemas dan berulang kali meminta ditemani. Interpretasi yang paling tepat terhadap kondisi pasien adalah

- A. pasien tidak mengalami sesak karena saturasi oksigen masih normal
- B. sesak napas hanya dapat dinilai melalui frekuensi pernapasan
- C. sesak napas merupakan pengalaman subjektif yang perlu dinilai berdasarkan laporan pasien
- D. kecemasan pasien tidak berkaitan dengan sensasi sesak napas
- E. sesak napas hanya terjadi jika ditemukan sianosis dan penggunaan otot bantu napas

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Dispnea bersifat subjektif.

Pembahasan:

Dispnea merupakan pengalaman subjektif berupa ketidaknyamanan dalam bernapas, seperti sensasi *air hunger*, napas terasa berat, atau perasaan tercekik. Tingkat keparahan sesak yang dirasakan pasien tidak selalu sejalan dengan hasil pemeriksaan objektif, termasuk saturasi oksigen dan frekuensi pernapasan.

Oleh karena itu, laporan pasien harus menjadi bagian utama dalam pengkajian. Data objektif tetap diperlukan untuk melengkapi penilaian, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyangkal pengalaman sesak yang disampaikan pasien.

Soal 2

Seorang pasien dengan kanker paru mengalami sesak akibat efusi pleura. Pasien juga merasa panik ketika sesak muncul, kehilangan perannya dalam keluarga, serta takut menghadapi kematian. Konsep yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi pasien tersebut adalah

- A. dispnea akut
- B. dispnea saat aktivitas
- C. gangguan ventilasi
- D. *total dyspnea*
- E. dispnea psikogenik

Kunci Jawaban: D

Kata Kunci: Dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Pembahasan:

Konsep *total dyspnea* menjelaskan bahwa pengalaman sesak napas pada pasien paliatif tidak hanya disebabkan oleh gangguan fisik. Dispnea juga dipengaruhi oleh kecemasan, perubahan peran sosial, dukungan keluarga, beban ekonomi, ketakutan terhadap kematian, serta kebutuhan spiritual.

Pada kasus tersebut, efusi pleura menjadi faktor fisik, kepanikan menjadi faktor psikologis, kehilangan peran sebagai faktor sosial, dan ketakutan menghadapi kematian sebagai faktor spiritual. Pengkajian serta penatalaksanaannya harus dilakukan secara holistik.

Soal 3

Seorang pasien PPOK lanjut mengalami gangguan pertukaran gas dan peningkatan resistensi jalan napas. Kondisi tersebut menyebabkan hipoksemia yang merangsang kemoreseptor dan meningkatkan dorongan bernapas. Namun, keterbatasan mekanika paru menyebabkan kebutuhan ventilasi tidak dapat dipenuhi secara adekuat. Mekanisme utama yang menimbulkan sensasi sesak pada kasus tersebut adalah

- A. keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan ventilasi
- B. ketidaksesuaian antara kebutuhan ventilasi dan kemampuan sistem respirasi
- C. penurunan rangsangan pada pusat pernapasan
- D. peningkatan kemampuan otot pernapasan
- E. penurunan persepsi sentral terhadap gangguan pernapasan

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: Ketidakseimbangan ventilasi.

Pembahasan:

Dispnea terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan ventilasi tubuh dan kemampuan sistem respirasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hipoksemia atau hiperkapnia meningkatkan rangsangan pada pusat pernapasan, tetapi gangguan seperti obstruksi jalan napas, penurunan *compliance* paru, atau kelemahan otot respirasi membatasi ventilasi.

Impuls dari kemoreseptor dan mekanoreseptor kemudian diproses oleh sistem saraf pusat, termasuk korteks serta sistem limbik. Proses ini menghasilkan persepsi subjektif sesak yang dapat semakin berat ketika pasien mengalami kecemasan atau panik.

Soal 4

Seorang pasien gagal jantung stadium akhir mengalami sesak saat berbaring. Pasien tampak cemas, bernapas cepat, dan menggunakan otot bantu napas. Tidak ditemukan stridor maupun penurunan kesadaran. Intervensi keperawatan awal yang paling tepat adalah

- A. memosisikan pasien semi-Fowler dan membimbing teknik pernapasan
- B. meminta pasien tetap berbaring agar kebutuhan energi menurun
- C. membatasi seluruh komunikasi agar pasien dapat beristirahat
- D. memberikan minum dalam jumlah besar untuk mengencerkan sekret
- E. melakukan pemeriksaan penunjang invasif sebelum memberikan kenyamanan

Kunci Jawaban: A

Kata Kunci: Posisi semi-Fowler dan manajemen pernapasan.

Pembahasan:

Posisi semi-Fowler membantu meningkatkan ekspansi paru dan mengurangi tekanan terhadap diafragma. Perawat juga dapat membimbing teknik pernapasan, seperti *pursed-lip breathing*, memberikan aliran udara dari kipas, menciptakan lingkungan tenang, serta memberikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan.

Intervensi harus disesuaikan dengan penyebab, kondisi klinis, dan tujuan perawatan pasien. Pemantauan frekuensi napas, pola napas, penggunaan otot bantu, tingkat kesadaran, dan saturasi oksigen tetap dilakukan secara berkelanjutan.

Soal 5

Setelah diberikan posisi semi-Fowler, latihan pernapasan, aliran udara dari kipas, dan dukungan emosional, pasien mengatakan sesaknya berkurang. Pasien tampak lebih tenang dan mampu berbicara dengan kalimat yang lebih panjang, meskipun saturasi oksigen tidak mengalami perubahan bermakna. Evaluasi yang paling tepat adalah

- A. intervensi tidak berhasil karena saturasi oksigen tidak meningkat
- B. intervensi harus dihentikan karena penyakit dasar masih progresif
- C. keberhasilan hanya dapat ditentukan melalui hasil pemeriksaan laboratorium
- D. pasien harus mencapai frekuensi napas normal sebelum dinyatakan membaik
- E. intervensi berhasil karena kenyamanan meningkat dan distress berkurang

Kunci Jawaban: E

Kata Kunci: *Comfort-oriented goals*.

Pembahasan:

Evaluasi asuhan pada pasien paliatif tidak hanya berfokus pada normalisasi parameter fisiologis. Keberhasilan juga dinilai dari berkurangnya sensasi sesak,

menurunnya kecemasan, meningkatnya kemampuan berbicara atau melakukan aktivitas ringan, serta tercapainya kenyamanan pasien.

Dalam kasus tersebut, laporan pasien bahwa sesak berkurang, kondisi yang lebih tenang, dan kemampuan berbicara yang membaik menunjukkan bahwa intervensi memberikan manfaat. Hasil ini perlu didokumentasikan secara objektif dan segera setelah evaluasi dilakukan.

Referensi

- Albrecht, T. A. e. a. (2025). *Oxford Textbook of Palliative Nursing*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780197657461.001.0001>
- Bausewein, C., Booth, S., Gysels, M., & Higginson, I. J. (2008). Non-pharmacological interventions for breathlessness in advanced stages of malignant and non-malignant diseases. *Cochrane Database of Systematic Reviews*(2).
- Bendowska, A., & Baum, E. (2023). The Significance of Cooperation in Interdisciplinary Health Care Teams as Perceived by Polish Medical Students. *Int J Environ Res Public Health*, 20(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph20020954>
- Booth, S., & Johnson, M. J. (2019). Improving the quality of life of people with advanced respiratory disease and severe breathlessness. *Breathe (Sheff)*, 15(3), 198-215. <https://doi.org/10.1183/20734735.0200-2019>
- Booth, S., Moffat, C., Burkin, J., Galbraith, S., & Bausewein, C. (2011). Nonpharmacological interventions for breathlessness. *Current Opinion in Supportive and Palliative Care*, 5(2), 77-86.
- Bruera, E., Higginson, I., Von Gunten, C. F., & Morita, T. (2015). *Textbook of palliative medicine and supportive care*. CRC Press.
- Campbell, M. L. (2012). Dyspnea prevalence, trajectories, and measurement in critical care and at life's end. *Curr Opin Support Palliat Care*, 6(2), 168-171. <https://doi.org/10.1097/SPC.0b013e328352b67f>
- Cherny, N. e. a. (2021). *Oxford Textbook of Palliative Medicine*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780198821328.001.0001>
- Februanti, S. (2020). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Kanker Serviks: Terintegrasi Dengan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), Dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) PPNI*. Deepublish.
- Feliciano, J. L., Waldfogel, J. M., Sharma, R., Zhang, A., Gupta, A., Sedhom, R., Day, J., Bass, E. B., & Dy, S. M. (2021). Pharmacologic Interventions for Breathlessness in Patients With Advanced Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Netw Open*, 4(2), e2037632. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.37632>
- Hanks, G. W. (2011). *Oxford textbook of palliative medicine*. Oxford University Press, USA.
- Kamal, A. H., Maguire, J. M., Wheeler, J. L., Currow, D. C., & Abernethy, A. P. (2011). Dyspnea review for the palliative care professional: assessment, burdens, and etiologies. *J Palliat Med*, 14(10), 1167-1172. <https://doi.org/10.1089/jpm.2011.0109>

- Kavalieratos, D., Gelfman, L. P., Tycon, L. E., Riegel, B., Bekelman, D. B., Ikejiani, D. Z., Goldstein, N., Kimmel, S. E., Bakitas, M. A., & Arnold, R. M. (2017). Palliative Care in Heart Failure: Rationale, Evidence, and Future Priorities. *Journal of the American College of Cardiology*, 70(15), 1919-1930. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.08.036>
- Kustanti, C. Y., & Nobe, N. (2024). Palliative care: "It is OK to be not OK". *The Journal of Palembang Nursing Studies*, 3(2), 54-57. <https://doi.org/10.55048/jpns112>
- Martina, D., Kustanti, C. Y., Dewantari, R., Sutandyo, N., Putranto, R., Shatri, H., Effendy, C., van der Heide, A., Rietjens, J. A. C., & van der Rijt, C. (2022). Opportunities and challenges for advance care planning in strongly religious family-centric societies: a Focus group study of Indonesian cancer-care professionals. *BMC Palliat Care*, 21(1), 110. <https://doi.org/10.1186/s12904-022-01002-6>
- Martina, D., Kustanti, C. Y., Dewantari, R., Sutandyo, N., Putranto, R., Shatri, H., Effendy, C., van der Heide, A., van der Rijt, C. C. D., & Rietjens, J. A. C. (2022). Advance care planning for patients with cancer and family caregivers in Indonesia: a qualitative study. *BMC Palliat Care*, 21(1), 204. <https://doi.org/10.1186/s12904-022-01086-0>
- Purqoti, D. N. S., Era, D. P., Kustanti, C. Y., Fadilah, A., Djuria, S. A., Hartini, S., & Pakpahan, H. M. (2025). *Buku Ajar Keperawatan Paliatif*. Penerbit Optimal Untuk Negeri.
- Pyszora, A., & Lewko, A. (2022). Non-pharmacological Management in Palliative Care for Patients With Advanced COPD. *Front Cardiovasc Med*, 9, 907664. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.907664>
- Rogers, J. B., Modi, P., & Minter, J. F. (2023). Dyspnea in palliative care. In *StatPearls [Internet]*. StatPearls Publishing.
- Shin, J., Kober, K., Wong, M. L., Yates, P., & Miaskowski, C. (2023). Systematic review of the literature on the occurrence and characteristics of dyspnea in oncology patients. *Crit Rev Oncol Hematol*, 181, 103870. <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2022.103870>
- Suha, F., Modi, P., & Sharma, S. (2025). Dyspnea. In *StatPearls [Internet]*. StatPearls Publishing.

Profil Penulis



Dewi Nur Sukma Purqoti.,Ns.,M.Kep.

Lahir di Dusun Pancordao, Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Mei 1987, Lulus D3 Keperawatan pada tahun 2008 di AKPER Yarsi Mataram yang saat ini menjadi STIKES YARSI Mataram, sebelum melanjutkan studi profesi Ners dan lulus pada tahun 2013 di STIKES Yarsi Mataram, ia pernah bekerja sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram dari tahun 2008-2010 dan pada tahun 2017 ia sukses menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) keperawatan peminatan keperawatan medikal bedah di Universitas Muhamadiyah Jakarta dengan judul thesis pengaruh Konseling Spiritual Terhadap kemampuan adaptasi psikologis pasien stroke. Dari tahun 2018 ia fokus meneliti tentang kasus-kasus paliatif. Dia juga aktif dalam organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Himpunan Perawat Holistik Indonesia (HPHI) NTB. Selain itu ia pun aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang dosen.

Email Penulis: purqotidewi87@gmail.com



Dr. Arie Kusumaningrum, S.Kep., M.Kep., Ns., Sp.Kep.An

lahir di Bantul, Yogyakarta pada 28 Januari 1976 merupakan seorang akademisi dan peneliti di bidang keperawatan yang telah mengabdikan diri di Bagian Keperawatan Universitas Sriwijaya sejak tahun 2003 hingga sekarang. Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Gadjah Mada (S.Kep. dan Profesi Ners), kemudian melanjutkan studi Magister Keperawatan Anak (M.Kep.) serta Spesialis Keperawatan Anak (Sp.Kep.An) di Universitas Indonesia. Pada tahun 2024, beliau meraih gelar Doktor dari Universitas Indonesia, semakin memperkuat kompetensinya dalam bidang keperawatan anak dan paliatif pediatrik. Penulis aktif melakukan penelitian yang berfokus pada keperawatan anak, manajemen nyeri pada bayi, dan perawatan paliatif pediatrik. Kontribusi dalam bidang perawatan paliatif anak tercermin dalam beberapa publikasi penting, antara lain *Pediatric Palliative Care: Pendekatan Konseptual dalam Perawatan Holistik Anak* (2024) dan studi tentang manajemen ansietas pada anak dengan leukemia.

Profil Penulis



Yuliati, SKp., MM., M.Kep.

1. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia. lulus pada tahun 1997
2. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Institut Magister Manajemen Indonesia lulus pada tahun 2002
3. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan Di Universitas Indoinesia lulus pada tahun 2015
4. Kandidat PhD di University Malaysiua Sabah (UMS)

Sejak tahun 2006 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan dan saat ini penulis aktif mengajar di Program Studi Ilmu Keperawatan fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, jakarta. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email yuliati@esaunggul.ac.id

Pesan untuk para pembaca:

Dengan penuh rasa syukur, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk mendalami materi dalam buku ini. Setiap halaman yang Anda baca menunjukkan komitmen, kepedulian, dan dedikasi Anda dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam memberikan perawatan yang lebih manusiawi dan bermakna bagi pasien. Kami percaya bahwa pengetahuan bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk diamalkan. Karena itu, besar harapan kami agar materi ini tidak sekadar menambah wawasan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi Anda untuk terus berkembang, memperkuat empati, serta membawa perubahan positif dalam praktik profesional sehari-hari.

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan pembelajaran ini. Semoga setiap ilmu yang diperoleh dapat menjadi cahaya yang menerangi langkah Anda dalam memberikan pelayanan terbaik bagi sesama. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan teruslah menjadi pribadi yang penuh manfaat bagi lingkungan Anda.

Motto: **“Living Your Life Well: Inspire, Grow, and Make a Difference.”**

Profil Penulis



Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Pall.C., Ph.D

Lahir di Yogyakarta, 29 Januari. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akademi Keperawatan Bethesda Yakkum Yogyakarta pada 1999. S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Charles Darwin University dan Flinders University, Australia di tahun 2010 dan 2013. Studi S3 diselesaikan pada 2023 di Taipei Medical University, Taiwan. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta sejak tahun 2003. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi artikel, pengelola jurnal (nasional/internasional), reviewer jurnal (nasional/internasional), ketua LPPM, narasumber seminar/pelatihan, penulis buku, serta *founder* untuk BerCa.my.id, sebuah *website* untuk dukungan *bereavement* secara virtual. Karya ilmiah penulis banyak berhubungan dengan perawatan paliatif, khususnya *bereavement care*, menggunakan berbagai pendekatan penelitian seperti kualitatif, *literature review*, dan meta-analysis. Penulis juga aktif sebagai pengurus himpunan perawat onkologi (HIMPONI) dan perawat paliatif (HPPI). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yeni@stikesbethesda.ac.id

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Paliatif ini disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, dan tenaga kesehatan yang ingin memahami konsep serta penerapan asuhan paliatif secara komprehensif. Keperawatan paliatif merupakan pendekatan perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit serius, kronis, progresif, atau mengancam jiwa. Melalui buku ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa pelayanan paliatif tidak hanya berorientasi pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta dukungan keluarga.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar keperawatan paliatif dan filosofi perawatan, termasuk prinsip-prinsip pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga. Selanjutnya, buku ini membahas identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif sebagai dasar dalam menentukan prioritas asuhan keperawatan. Penilaian yang tepat menjadi bagian penting dalam memahami kondisi pasien secara menyeluruh, sehingga perawat mampu merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan harapan pasien.

Buku ini juga menguraikan manajemen nyeri dalam perawatan paliatif sebagai salah satu aspek utama dalam meningkatkan kenyamanan pasien. Selain itu, pembahasan mengenai manajemen sesak napas dan gejala respirasi disajikan untuk membantu pembaca memahami penanganan gejala yang sering menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup. Dengan penyajian yang sistematis, aplikatif, dan berorientasi pada praktik keperawatan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membentuk tenaga keperawatan yang kompeten, empatik, komunikatif, dan profesional dalam memberikan asuhan paliatif.

Buku Ajar Keperawatan Paliatif ini disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, dan tenaga kesehatan yang ingin memahami konsep serta penerapan asuhan paliatif secara komprehensif. Keperawatan paliatif merupakan pendekatan perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit serius, kronis, progresif, atau mengancam jiwa. Melalui buku ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa pelayanan paliatif tidak hanya berorientasi pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta dukungan keluarga.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan konsep dasar keperawatan paliatif dan filosofi perawatan, termasuk prinsip-prinsip pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga. Selanjutnya, buku ini membahas identifikasi kebutuhan paliatif dan penilaian komprehensif sebagai dasar dalam menentukan prioritas asuhan keperawatan. Penilaian yang tepat menjadi bagian penting dalam memahami kondisi pasien secara menyeluruh, sehingga perawat mampu merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan harapan pasien.

Buku ini juga menguraikan manajemen nyeri dalam perawatan paliatif sebagai salah satu aspek utama dalam meningkatkan kenyamanan pasien. Selain itu, pembahasan mengenai manajemen sesak napas dan gejala respirasi disajikan untuk membantu pembaca memahami penanganan gejala yang sering menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup. Dengan penyajian yang sistematis, aplikatif, dan berorientasi pada praktik keperawatan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membentuk tenaga keperawatan yang kompeten, empatik, komunikatif, dan profesional dalam memberikan asuhan paliatif.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-95-4 (PDF)



9

786347

756954

